

针灸学-中

光明中医函授大学

电子版制作时间：2025-02-19

针灸学-中

中篇 针灸术

第一章毫针

第一节毫针的基本知识

第二节针刺练习

第三节针刺前的准备

第四节毫针刺法

一、进针

二、针刺的角度和深度

三、行针与得气

四、针刺补泻

五、留针与出针

[临床应用]

1.针刺角度与深度:

2.得气:

3.针刺补泻:

第五节异常情况的处理及预防

第二章灸法 附:拔火罐疗法

第一节灸用材料

第二节灸法的分类及其操作

第三节灸法的作用

第四节灸法的注意事项

[附]拔罐法

第三章其他针法

第一节三棱针

第二节皮肤针

第三节皮疗针

第四节火针

第五节电针

第六节水针

第七节耳针

一、耳廓表面解剖

二、耳与经络脏腑的关系

三、耳穴的分布

四、常用耳穴的定位和主治

五、耳针的应用

(一)选穴处方原则

(二)操作方法

六、注意事项

[临床应用]

第八节头针

第四章其他针法

第一节针麻概念和简史

第二节针麻特点和方法

一、针麻特点

二、针麻方法

第三节针麻的要求及辅助用药

更多信息

中篇 针灸术

- 中篇 针灸术

针法和灸法，是针灸临床治疗中所必须掌握的基本技能，在针灸医学中占有极重要的地位。历代针灸医家，对此曾积累了极为丰富的实践经验和理论基础。针法和灸法的种类很多，本篇介绍常用的针灸法，包括毫针、灸法（附：拔罐法）、三棱针、皮肤针、皮内针、火针、水针、埋线、耳针、头针以及针刺麻醉等。

第一章毫针

〔自学时数〕8学时

〔面授时数〕2学时

〔目的要求〕

1. 了解九针的名称、形状及用途。
2. 了解毫针的构造和规格。
3. 掌握针刺前的准备。
4. 掌握毫针的刺法，包括进针、留针、出针等全部操作，并重点掌握捻转、提插、疾徐等补泻手法。
5. 熟悉进针的角度、深度和得气的意义。
6. 熟悉候气、催气，行针等操作方法。
7. 掌握针刺异常情况的预防和处理。
8. 熟悉针刺注意事项。

第一节毫针的基本知识

近代的毫针，是从古代的九针基础上发展而来。不仅制针的质料有金、银、不锈钢等不同，而且制针的工艺和形状亦有很大改进。现将九针及近代毫针分述如下：

一、九针

从砭石发展到九针，这时才有正式的针法，在《灵枢·官针》篇中说：“九针之宜，各有所为，长短大小，各有所施。”说明九种不同形状的针具各有不同的用途，在针灸医学发展上起了很大作用（图196）。

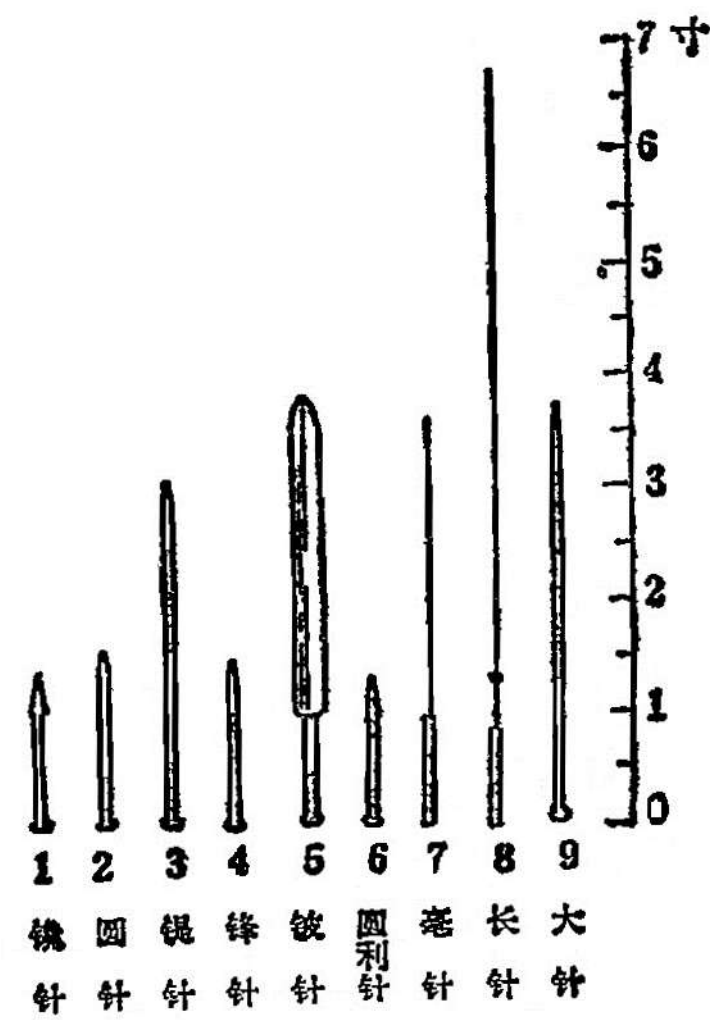


图 196 古代九针图

(1) 镵针

形状：长一寸六分，形似箭头，头大末锐，当末端一分处收小，形成尖端，后人有称为“箭头针”。近人在此基础上发展为皮肤针。

用途：浅刺皮肤而不能深入，用于浅刺皮肤泻血，治头身热症等。

（2）圆针

形状：长一寸六分，针身圆柱形，针头卵圆，后人有称为“圆头针”。

用途：揩摩体表，治分肉间气滞，不伤肌肉。为按摩用具。

（3）鍤针

形状：长三寸半，针头如黍粟形，圆而微尖，近人有称为“推针”。

用途：按压经脉，不能深入（按脉勿陷）为按压穴位的用具。

（4）锋针 形状：长一寸六分，针身圆柱形，针尖锋利，呈三棱锥形，后人称为三棱针。

用途：用于泻血，治疗痈肿、热病。

（5）铍针

形状：长四寸，宽二分半。形如剑，后人有称为剑头针。

用途：痈肿外症割治用。

（6）圆利针

形状：长一寸六分，末端尖锐，中部略膨大，针身反细小圆而且利。

用途：痈肿、痹证的深刺。

（7）毫针

形状：长一寸六分或三寸六分，针身细如毫（豪）毛。

用途：通调经络，治寒热、痛痹等。

（8）长针

形状：长七寸，针身细长而尖部锋利。后人称为环跳针，近人又称为芒针。

用途：深刺，治“深邪远痹”。

（9）大针

形状：长四寸，针身粗圆。

用途：泻水，“取大气之不能过于关节者”，治关节积液，后人作火针用，治癰疽、乳癰等症。

二、毫针的构造、规格和保藏

（一）毫针的构造和规格

1.毫针的构造：毫针是针刺治病的主要针具，临床上应用最广。制针的原料以不锈钢为主，但也有金、银或合金制成的。

毫针的构造可分为五个部分（图197）。

图197毫针的构造



图 197 毫针的构造

- （1）针尖：针的尖端锋锐部分称针尖，亦名针芒。其状似松针，是接触腧穴刺入机体的前锋。
- （2）针身：针尖与针根之间称为针身。针身宜光滑挺直，富有弹性。
- （3）针根：针身与针柄连接处称为针根。
- （4）针柄：手持处称针柄。是以铜丝或铝丝将针的一端呈螺旋形的紧密缠绕而成，是持针着力部分。
- （5）针尾：针柄的末端称针尾。一般是用铜丝或铝丝横行缠绕呈圆筒状，是温针装置艾绒的部分。

2.毫针的规格：主要是指针身的粗细和长短。目前所用毫针的长短、粗细规格分别如表9、10。

表9、毫针的长短规格

寸	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
毫米	15	25	40	50	65	75	90	100	115	125

表10、毫针的粗细规格

号数	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
直径（毫米）	0.45	0.42	0.38	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.23	0.22

临床上以28~30号粗细和1~3寸长者最为常用。短针多用于耳穴及体穴浅刺，长针多用于肌肉丰厚部位腧穴的深刺。

3.毫针的修藏：毫针的修藏是指对针具的维修和保藏。保藏针具，是为防止针尖受损、针身弯曲或生锈、污染等。藏针的器具有针盒、针管和藏针夹等。使用针盒藏针时，在盒内多垫几层消毒纱布，将消毒后的针具，根据毫针的长短分别置于盒内，再用消毒纱布敷盖，以免污染，然后将针盒盖好备用。使用藏针夹藏针时，针夹两侧要放有硬纸板（防止针身弯曲），夹内放多层消

毒纱布，放入消毒后的针具，然后合上针夹备用。使用针管藏针时，针管的一端放入干棉球（以防针尖损坏钩曲），然后将针置入，盖好备用。

针是治病的工具，在使用过程中，应随时注意针尖是否有钩曲或过钝，针身是否有弯曲等。若针身弯曲，针尖过钝或有钩曲，不仅直接影响进针，而且使病人感到刺痛，影响治疗效果。因此对针具应随时检查，经常维修，现将针具的检修方法介绍如下：

（1）针身的检修：检修时应注意针身有无锈蚀，急弯或一般弯曲。若一般弯曲可用手指或竹板夹住针身，将针身捋直。若属急弯，针身有锈蚀，一般剔之不用，以免折针。同时也应检查针柄与针身是否衔接牢固，形成一体，如针身与针柄接触不牢，则不宜应用。

（2）针尖检修：检修时应注意针尖有无钩曲，针尖钝和针尖偏斜。若针尖不正、有钩、过钝时，可用细砂纸或细磨石磨好，使针尖正直光滑，圆而不钝，利而不锐，过锐则易弯成钩，过钝则易痛，应磨成如松针形为宜。

〔临床应用〕

近代的毫针就是在九针的基础上发展起来的，不论是从结构上，规格上渐趋精巧，便于临床应用。了解毫针的结构和规格之后，一方面便于毫针的检查，另一方面便于临床选用不同规格的毫针，选针适当，便于不同穴位的针刺，才能提高疗效，防止意外事故的发生。毫针的修藏，主要是延长针具的使用寿命和防止针刺的疼痛以及意外事故的发生有一定作用。

复习思考题

1. 九针的名称和用途是什么？
2. 毫针的构造、规格是什么？哪些规格的针临床治疗时最常用？
3. 毫针如何维修和保藏？

第二节针刺练习

针刺练习，主要是对指力和手法的锻炼。为了达到针刺的治疗目的，不使病人增加痛苦，就要熟练掌握进针和进行各种手法的操作。由于毫针针身细软，要把毫针刺入肌肤内，没有一定的指力是不行的。指力只有通过练习才能掌握，所以练习指力是初学针刺者的重要基本技能训练。指力是进针顺利，减轻疼痛，提高疗效的基本保证。对初学者在临床操作之前，首先要有练习指力的过程。

1. 纸垫练针法：

用松软的纸张，折迭成长约8厘米，宽约5厘米，厚约2~3厘米的纸块，用线如“井”字形扎紧，做成纸垫，练针时左手执纸垫，右手拇、食、中、环、小五指持针柄，如持笔状地持1.0~1.5寸毫针，使针尖垂直地抵在纸块上，然后右手拇指与食、中、环、小四指前后交替地捻动针柄，并逐渐加一定的压力，待针穿透纸垫后另换一处，反复练习。纸垫练习主要是锻炼指力和捻转的基本手法（图198）。

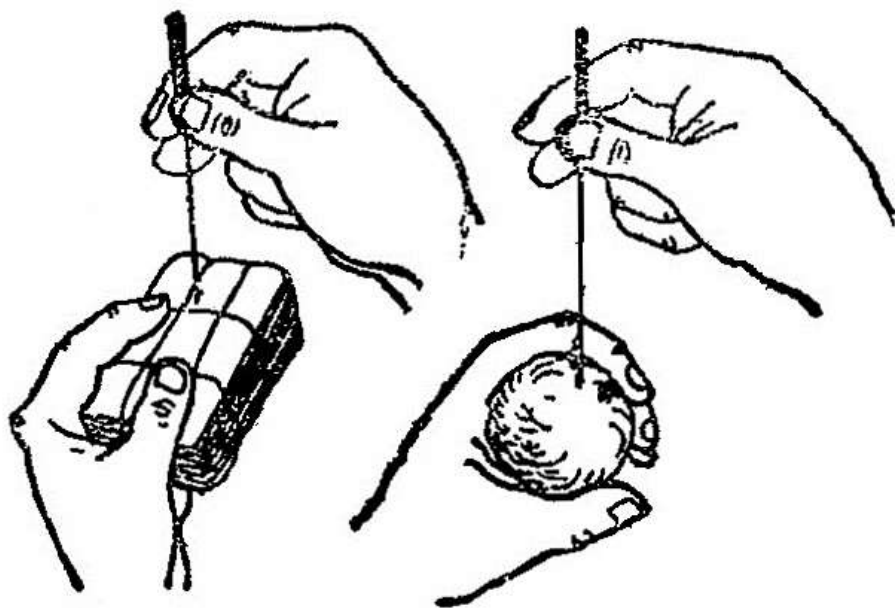


图 198 纸垫、棉团练针

2. 棉团练针法：

用布将棉花包裹，用线封口扎紧，做成直径 约6~7厘米的棉团，练针方法同纸垫练针法，所不同的是棉团松软，可以做提插、捻转等多种基本手法的练习（图198）。

在进行练针时，要做到捻转的角度大小，捻转的速度，可以随意掌握，来去的角度力求一致，快慢均匀。在这一过程中也可配合上下提插的练习，一般总的要求是提插幅度，上下一致，捻转角度来去一致，频率的快慢一致，达到得心应手，运用自如。但纸垫或棉花团与人体有一定的差异，为了体验不同的针刺手法所产生的不同作用，最好在自己身上进行练针，以便临床针刺施术时，心中有数，提高针刺手法水平。

〔临床应用〕

针刺练习是掌握针刺技术的基本功之一。练针就是练习指力，所谓指力包括手指的力量和手腕力量的两个方面，握针靠手指的力量，进针靠手腕的力量，手指和手腕这两个力量要配合好，才能把又细又软的毫针刺入穴位内，进针即顺利又能减少疼痛，操作灵活自如。所以初学者在针刺之前，必须加强指力的锻炼，刻苦练习指力，才有针刺的基本功。练针除了练指力外，还要练习进针的角度和深度，才能掌握针刺治疗时的要求，既能提高治疗效果，又能防止意外事故的发生，所以练针是初学者不可缺少的基本功。

复习思考题

1. 练针的意义及目的何在？
2. 怎样进行针刺练习？

第三节针刺前的准备

一、选择针具

对针具的选择，现在多选用不锈钢所制针具，因不锈钢不仅能防腐蚀、能耐热，而且具有一定的硬度、弹性和韧性。金质和银质的针，弹性较差，价格昂贵，故临床较少应用。从质优的毫针中应选择针柄无松动，针身挺直光滑，坚韧而富有弹性，针尖圆而不钝，利而不锐，呈松针形者为好。如针身有缺损和伤痕者，应剔出不用，以免在针刺施术过程中，给病人造成不必要的痛苦。

在选择针具时，除应注意上述事项外，在临床上还应根据病人的性别、年龄的长幼、形体的胖瘦、体质的强弱、病情的虚实、病变部的表里深浅和所取穴位的具体部位，选择长短、粗细适宜的针具。《灵枢·官针》说：“九针之宜，各有所为，长短大小，各有所施也”。如男性，体壮、形肥、病变部位较深者，可选稍粗、稍长的毫针。反之若女性、体弱、形瘦，而病变部位较浅者，就应选用较短、较细的毫针。至于根据腧穴所在具体部位进行选针时，一般是皮薄肉少之处和针刺较浅的腧穴，选择针具宜短而针身宜细；皮肤厚肌肉多而针刺宜深的腧穴，宜选用针身稍长和稍粗的毫针。在临床选针的长短时，除刺入的深度外，针身还应露出皮肤表面3~5分为宜。

二、解释工作

在临床上医生给初诊病人针刺时，应耐心的向病人解释针刺的一般常识，减少病人对针刺的恐惧心里，从而取得病人的积极配合，以便更好的发挥针刺的治疗作用，并可避免针刺异常情况的发生。

三、选择体位

为了使病人适应针灸施术，针刺前应根据所选的腧穴，指导病人选择适当的体位。病人体位选择是否得当，对腧穴的正确定位，针刺的施术操作，持久的留针，以及防止晕针、滞针、弯针，折针等；都有很大影响，如病重体弱或精神紧张的病人，采用坐位，易使病人产生疲劳，往

往易发生晕针。又如体位选择不当，在针刺施术时或在留针过程中，病人常因移动体位而造成弯针、滞针甚至发生折针事故。因此说选择体位具有重要意义。

（一）选择体位的一般原则 1. 选择体位应该是以医生能正确取穴，操作方便，患者体位舒适，并能持久为原则。

2. 在可能条件下，一种体位能暴露出针灸处方所列的腧穴。

3. 一般可采取卧位，尤其是精神不好，或精神过度紧张，体质虚弱的患者最好采取卧位，防止晕针或其他事故。

4. 在比较冷的条件下，应采取少暴露皮肤面上的穴位，以防受凉或感冒。

（二）临床常用体位 临床常用体位一般以卧位和有倚靠的坐位为主，分述如下：

1. 仰卧位：适用于取头、面、胸、腹部腧穴，和上、下肢的部分腧穴（图199）。

2. 侧卧位：适用于取身体侧面少阳经腧穴和上、下肢的部分腧穴（图200）。

3. 俯卧位：适用于取头、项、脊背、腰尻部腧穴和下肢后面的腧穴（图201）。

4. 仰靠坐位：适用于取前头、颜面和颈前等部位的腧穴（图202）。

5. 俯伏坐位：适用于取后头和项、背部腧穴（图203）。

6. 侧伏坐位：适用于取头部一侧、面颊及耳前后部位的腧穴（图204）。

总之，患者的体位一定要舒适，取穴准确，医生针灸操作方便可即。



图 199 仰卧位



图 200 侧卧位

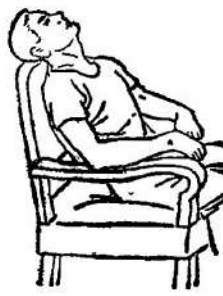


图 202 仰靠坐位

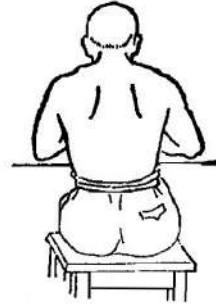


图 203 俯伏坐位



图 201 俯卧位



图 204 侧伏坐位

四、消毒

针刺前的消毒工作，包括针具消毒，医者手指消毒，腧穴部位消毒。消毒的方法，可根据具体条件选用以下方法。

（一）针具消毒 可根据具体条件选用下列消毒方法：

1. 高压消毒法：将针具修好后，用纱布包好，放在针盒内，置于高压消毒锅内，一般需要在15磅气压，温度应达 120°C ，消毒时间应为15分钟以上，即达到消毒的目的。
2. 煮沸消毒法：将针具修检好后用纱布包好，放置在清水锅内，待水沸腾后，再煮15分钟即可。为了提高沸点，应在水中加入重碳酸钠，使之成为2%的溶液，可以提高水的沸点达 120°C ，并且有减低沸水对针具的腐蚀作用。
3. 药物消毒：将修好的针具置于75%酒精溶液内，浸泡30分钟即可达到消毒要求。亦可用0.1%的新洁尔灭浸泡并加防腐剂 0.5%浓度的亚硝酸钠，浸泡30分钟即可达到消毒作用。取出后用消毒纱布擦干，放在消毒的针盒内备用。还可使用2%来苏溶液或1:1000的升汞溶液浸泡1~2小时后应用。对某些传染性疾病患者，应做到一针一穴，一次性使用。

总之，不管哪种消毒方法，只要达到消毒要求即可。

（二）医者手指消毒 在施术前，医者先用肥皂水将手洗刷干净，待干后再用75%酒精棉球擦拭即可。施术时医者应尽量避免手指直接接触针体，如必须接触针体时，可用消毒干棉球作间隔物，以保持针身无菌，以免感染。

（三）施术部位消毒 在患者需要针刺的腧穴部位消毒时，可用75%酒精棉球拭擦即可。在拭擦时应由腧穴部位的中心向四周绕圈拭擦。或先用2%碘酒棉球拭擦，然后再用75%酒精棉球涂擦脱碘消毒，当穴位消毒后，切忌接触污物，以免重新污染。

五医者的态度

医者的态度是整个治疗工作中的关键问题，首先要有急病人之所急，痛病人之所痛这种感情，全心全意为患者服务，只有医生关心病人，病人才能相信医生，这种医患合作，有利于病人战胜疾病的信心。这就要求医生要有严肃的态度，精神要集中，专心一意的为患者治疗，尽到医生的职责。《灵枢·九针十二原》：“祖守形，上守神”。在患者方面也必须树立针灸治疗的信心，对疾病要有战胜的决心，这要医生帮助树立。只有调动医生、患者两个方面的积极性，才能收到满意的治疗效果。

〔临床应用〕

临床上应用的针具，都应选择优质的针，而劣质的针具应剔除不用。在选择毫针的粗细、长短时，要根据患者的性别、年龄、形体、体质、虚实、表里来进行选择。凡是体质壮实，肌肉丰满，实热证选择粗针长针；凡体质虚弱，肌肉瘠薄，虚寒证选择细针短针。否则就会影响针灸的治疗效果。消毒也是针刺治疗中很重要的环节，针具和腧穴部位消毒要彻底就会防止感染，有利于患者身体健康。体位的选择要根据疾病的诊断、处方中的腧穴来选择，选择的体位应该是以医者能正确取穴，操作方便；患者又感到舒适持久为原则，以免引起疼痛或弯针、断针等异常情况的出现。

复习思考题

1. 针刺前要做哪些准备工作？
2. 用高压气锅消毒针具需要多大压力？多高温？多长时间？
3. 煮沸消毒针具，应煮沸多长时间？为了提高沸点，应采取什么措施？
4. 针刺消毒包括哪些方面？常用的消毒方法是什么？
5. 常用的针灸体位有几种？各适用于针灸哪些穴位？

第四节毫针刺法

毫针刺法有着很高的技术要求和严格的操作规程，医生必须掌握从进针到出针这一系列的操作技术。

一、进针

把针刺入皮肤内就是进针。进针是针刺操作的基本手法。在进行针刺操作时，一般均须双手协作，互相配合，才能把针迅速刺入皮肤。正如《流注指微论》中指出：“针入贵速，即入徐进”。持针施术的手称“刺手”；按压穴位局部，帮助施术的手称为“押手”。《针经指南·标幽赋》指出：“左手重而多按，欲令气散；右手轻而徐入，不痛之因”。刺手就是拿针的手，一般习惯都称右手为刺手（图205）。持针的方法是根据治疗的需要来决定的，常用持针方法有以下四种：

1. 执笔式持针法：一般用右手拇食指挟持针柄，中指抵住针身，进针时帮助着力，防止针身弯曲，使着力点集中到针尖上进行针刺。
2. 拇食指持针法：右手拇食二指持住针柄，进行针刺。
3. 拇中指持针法：右手拇中二指持住针柄，进行针刺。
4. 拇食，中指持针法：右手拇中二指持住针柄，食指放在针尾上，稍再力下压，帮助进行针刺。

刺手的作用：是掌握针具，进针时运用指力，使针尖迅速刺透皮肤，掌握进针的角度、方向、深度、刺激的强度，便于对身体不同部位腧穴的针刺，行针时进行适当的捻转、提插等手法进行施术。



图 205 持针姿势

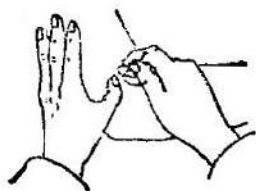


图 206 指切进针法

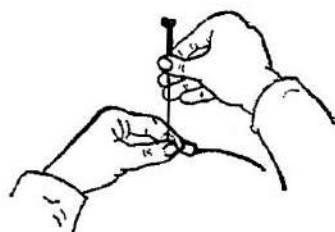


图 207 夹持进针法

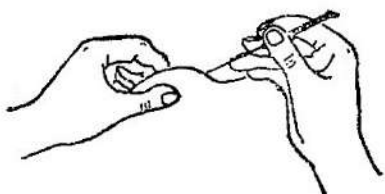


图 208 提捏进针法

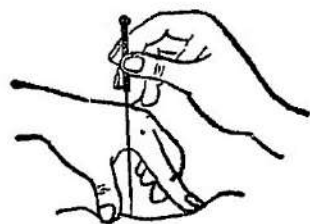


图 209 舒张进针法

押手就是辅助施术的手，一般习惯都称左手为押手，是根据腧穴的位置和用针的长短而定。临床常用的进针方法有以下四种：

1. 指切进针法：又称爪切进针法，用左手拇指或食指端切按在腧穴位置的旁边，右手持针，紧靠左手指甲面将针刺入腧穴。此法多用于短针的进针。如针刺睛明、球后、内关、足三里等腧穴（图206）。

2. 夹持进针法：或称骈指进针法，即用左手拇食二指持捏消毒干棉球，夹住针体下端，将针尖固定在所刺腧穴的皮肤表面位置，右手捻动针柄，将针刺入腧穴。此法是双手配合，适用于长针的进针。如针刺环跳、秩边、殷门等腧穴（图207）。

临床上也有采用插刺进针的，即单用右手拇、食二指夹持消毒干棉球，夹住针身下端，使针尖露出2~3分，对准腧穴位置，将针迅速刺入腧穴，然后将针捻转刺入一定深度，并根据需要选用适当押手配合行针。

3. 提捏进针法：用左手拇、食二指将针刺腧穴部位的皮肤捏起，右手持针，从捏起的上端将针刺入。此法主要用于皮肉浅薄部位的腧穴进针，

如印堂、阳白、水沟、地仓等腧穴（图208）。

4. 舒张进针法：用左手拇、食二指将针刺腧穴部位的皮肤向两侧撑开，使皮肤绷紧，右手持针，使针从左手拇、食二指的中间刺入。此法主要用于皮肤松弛部位的腧穴，如中脘、关元、归来、四满等腧穴（图209）。

押手的作用：正如《难经·七十六难》指出：“知为针者信其左，不知为针者信其右”。这说明在针刺时不能单靠右手，左手帮助进针时起着很重要作用。其作用一般可分为以下四种：

1. 可以固定穴位，使进针时不移动位置，准确刺入腧穴，避开脏器器官和血管。

2. 可以帮助进针时的指力，使针不致于弯曲。

3. 可以减少进针时的疼痛，压则气散，不伤营卫，缓解肌肉紧张。正如《标幽赋》中记载：“左手重而多按，欲令气散；右手轻而徐入，不痛之因”。这是窦汉卿总结前人的经验，直到今天，仍为针灸临床广泛采用。

4. 可以加强针刺的作用，提高治疗效果。即“欲气上行，按之在后，欲气下行，按之在前”，可使针感按临床治疗的要求去传导，趋向病所。

除上述的进针方法外，还有采用针管进针的，即备好玻璃或专属制成的针管，针管长度要比毫针短2—3分，以便露出针柄，针管的直径以能顺利通过针尾为宜，进针时左手持针管，将针装入管内，针尖与针管下端平齐，置于应刺的腧穴上，针管上端露出针柄2~3分，用右手食指叩打针尾或用中指弹击针尾，即可使针刺入，然后退出针管，再运用行针手法进行操作。

二、针刺的角度和深度

在针刺操作过程中，掌握正确的针刺角度、方向和深度，是增强针感，提高疗效，防止意外事故发生的重要环节，腧穴定位的正确，不应仅限于体表的位置，还必须与正确的进针角度、方向、深度等有机的结合起来，才能充分发挥其应有效应。临床上同一腧穴，由于针刺的角度、方向、深度不同，所产生针感的强弱、感传的方向和治疗效果常有明显的差异。正确掌握针刺角度、方向和深度，要根据施术腧穴所在的具体位置，病人体质，病情需要和针刺手法等实际情况，灵活掌握，现分述如下：

（一）针刺角度 针刺的角度是指进针时针身与皮肤表面所构成的夹角。它是根据腧穴所在的位置和医者针刺时所要达到的目的结合而定。一般分为直刺、斜刺、平刺三种(图210)。

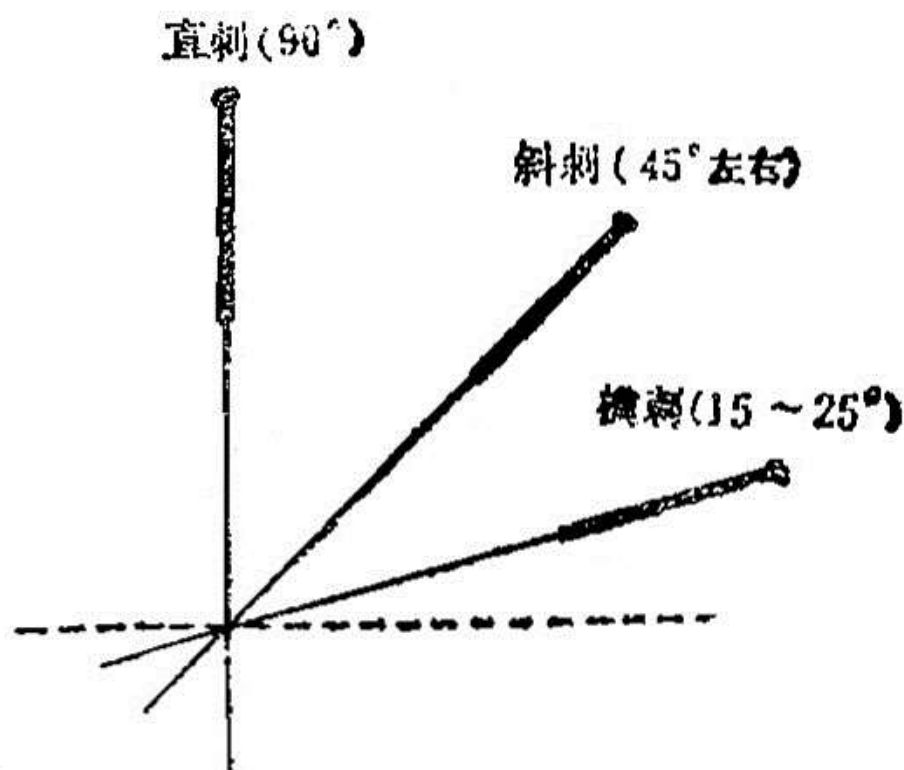


图 210 针刺的角度

1. 直刺：即针身与皮肤表面呈 90° 角垂直刺入。此法适用于肌肉丰厚处的腧穴或腹部的腧穴，如臀部、腹部及四肢等部位的腧穴。
2. 斜刺：即针身与皮肤表面呈 45° 角倾斜刺入。此法适用于肌肉较薄处或内有重要脏器的部位，如胸、背、骨间隙等部位的腧穴。
3. 平刺：又称“横刺、沿皮刺”即针身与皮肤表面呈 15° 角沿皮刺入。此法适用于肌肉特别浅薄处，如头、胸部位的腧穴，有时在透穴刺法时也用这类针刺角度。

（二）针刺深度 针刺深度是指针身刺入皮肉内的深度而言。一般以既有针感又不伤及重要脏器为原则。《素问·刺要论》指出：“病有沉浮，刺有深浅，各至其理，无过其道”。每个腧穴的针刺深度，在腧穴各论中已有详述，在此仅根据下列情况，作原则的介绍。

1. 年龄：年老体弱及小儿娇嫩之体，宜浅刺；中青年身体强壮，气血旺盛者，宜深刺。如《灵枢·逆顺肥瘦》：“婴儿，瘦人，浅而疾之，壮士肥人，深而留之”。

2. 体形：体壮的胖人，肌肉丰盛者，针刺应深些；体形瘦小，肌肉不那么丰满者，针刺应浅些。如《素问·三部九候论》说：“必先度其形之肥瘦，以调其气之虚实”。

3. 部位：头面及胸背部和皮薄肉少处的腧穴，宜浅刺；四肢及臀、腹部和肌肉丰满处的腧穴，宜深刺，《针灸聚英·附辨》：“若肌肉厚实处则可深，浅层则宜浅”。

4. 病情：病在表、阳证、新病者针刺应浅些；病在里、阴证、久病者针刺应深些。如《素问·刺要论》说：“病有沉浮，刺有浅深”。

综上所述，针刺的角度和深度之间，有着相辅相成的密切关系，一般来讲，深刺多用直刺，浅刺多用斜刺或平刺。尤其对天突、哑门、风府、风池以及眼区、胸背部腧穴和重要脏器如心、肝、肺等部位的腧穴，要掌握好针刺的角度和深度。至于不同季节、对针刺深浅也有影响，也应予以重视。

三、行针与得气

行针亦称运针，是指将针刺入腧穴后，为了使之得气，激发针感以及进行补泻而施行的各种针刺手法。得气又称针感，是指针刺入穴位后所产生的经气感应。当这种经气感应产生时，患者感到针下出现相应的痠、麻、胀、重感，或抽搐，有的也出现温热、凉爽、烧灼、触电样感，在针刺的局部或从针下向远端放散。医者则有针下沉紧、沉涩、沉重感觉，如同磁铁吸引针一样。所以《标幽赋》说道：“气之至也，如鱼吞钩饵之沉浮”。又说“沉涩紧而已至”。说明医者有沉紧、沉涩、沉重感觉，即是得气。起到疏通经气、调和气血的作用。如果针刺不得气，患者则没有什么感觉，而医者感到针下虚滑，如同针刺豆腐一样的感觉。《标幽赋》描写道：“轻滑慢而未来”，“气未至也，如闲处幽堂之深邃”。说明针与“经气”没有沟通。

从针刺治病和针刺麻醉以及经络感传研究的实践证明，针感的有无及强弱，直接关系到治疗效果的好坏。因此，古今医家都很重视针刺的得气，《灵枢·九针十二原》指出：“为刺之要，气至而有效。效之信，若风之吹云，明乎若见苍天”，《金针赋》说：“气速至而效速，气迟至而不治”。这都说明得气与否，是治疗成败的关键。一般来说，得气迅速，疗效就好；得气迟缓，疗效就差，如不得气，则可能无效。因此，在针刺过程中，如果得气较慢，甚至不得气，就要分析不得气的原因。或因取穴定位不准确，手法运用不当；或因针刺角度有误，深浅失度。对此就应重新调整腧穴的针刺部位、角度、深度，运用必要的针刺手法，这样再次行针时，一般即可得气。如果患者病久体虚，正气虚惫，以致经气不足；或因其他病理因素，感觉迟钝、丧失而不易得气时，可采用行针催气，或留针候气，或用温针，或加艾灸，以助经气的来复，而促使得气，或因治疗而随着疾病转愈，而经气逐渐得到恢复，针刺时则迅速得气。若用上法而仍不得气者，多为脏腑经络之气虚衰已极。正如《针灸大成·经络迎随设为问答》中说：“只以得气为度，如此而终不至者，不可治也”。对此，当考虑配合或改用其他治疗方法。

现将临床常用的行针基本手法和辅助手法介绍如下：

（一）行针基本手法 行针基本手法，是针刺基本动作，常用的有提插法和捻转法两种。

1. 提插法：是将针刺入腧穴的一定深度后，使针在穴内进行上、下进退的操作方法。使针从浅层向下刺入深层为插；由深层向上退到浅层为提（图211）。提插的幅度大、频率快、操作时间长，则刺激量大；提插幅度小、频率慢，操作时间短，则刺激量小。应根据病人的体质、病情和腧穴的部位以及医者所要达到的目的而灵活掌握。但不能提插幅度过大，使深部组织受损害，以提插幅度3~5分深为宜。

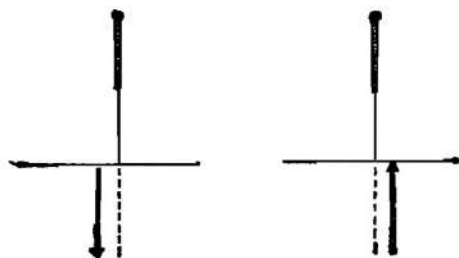


图 211 提插法



图 212 捻转法(左转)



图 213 捻转法(右转)



2. 捻转法：是将针刺入腧穴的一定深度后，将针左右来回旋转捻动的操作方法（图212、213）。捻转的角度大，频率快，操作时间长，则刺激量大；捻转的角度小，频率慢，操作时间短，则刺激量小。应根据病人的体质、病情和腧穴的部位特征以及医者所要达到的目的而灵活运用。但捻转角度不要超过360°，更不能向一个方向捻转，即顺时针或逆时针捻转180°为宜。否则针身缠绕肌纤维而发生疼痛。

以上两种基本手法，既可单独使用，也可互相配合应用，在临床上必须根据病人的具体情况，灵活掌握，才能发挥其应有作用。

(二)行针辅助手法 是进行针刺时，用以辅助行针的操作方法。常用的有以下几种：

1. 循法：是以左手或右手于所针刺腧穴的周围或沿经脉的循行部位轻轻地循按的方法（图214）。此法在未得气时用之，可以通气活血，有行气、催气之功。

2. 弹法：是将针刺入腧穴的一定深度后，以手指轻弹针柄，使针体微微震动，以加强针感（图215）。《针灸问对》说：“如气不行，将针轻轻弹之，使气速行，……故曰弹以催气”。

3. 刮法：是将针刺入腧穴的一定深度后，用拇指或食指的指腹抵住针尾，以拇指、食指或中指爪甲，由下而上的频频刮动针柄的方法（图216）。此法在不得气时，用之可激发经气，促使得气或者加强针感和促使针感的扩散。

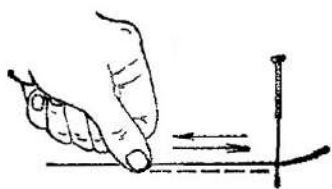


图 214 循法

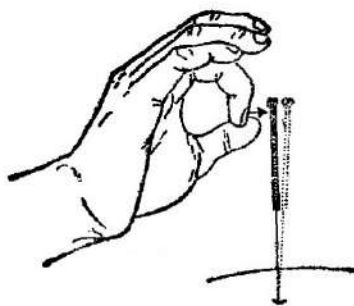


图 215 弹法

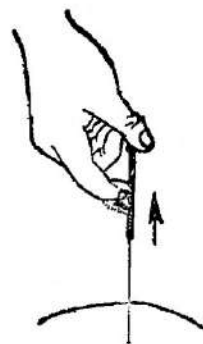


图 216 刮法

4. 摇法：是将针入腧穴的一定深度后，手持针柄进行摇动，可以行气（图217）。若直立针身而摇，可以加强针感；卧倒针身而摇，往往可以促使针感向一定方向传导。

5. 飞法：是将针刺入腧穴的一定深度后，以捻转为主，一般将针先作较大幅度的捻转，然后松手，拇、食指张开，一捻一放，反复数次，如飞鸟展翅之状，可以使针感增强（图218）。《医学入门》说：“以大指、次（食）指捻针，连搓三下，如手颤之状，谓之飞。”

6. 震颤法：是将针刺入腧穴的一定深度后，右手以拇、食、冲三指挟持针柄，用小幅度、快频率的提插捻转动作，使针身产生轻微的震颤，以增强针感（图219）。

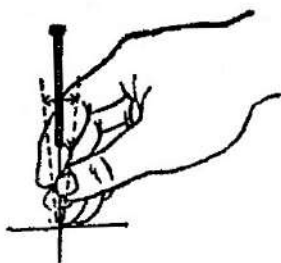


图 217 摇法

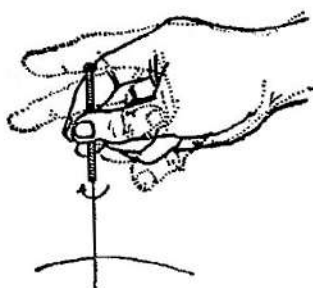


图 218 飞法

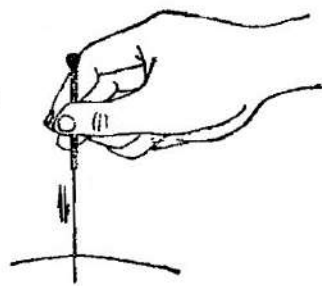


图 219 震颤法

四、针刺补泻

针刺补泻，是根据《灵枢·经脉》：“盛则泻之，虚则补之，寒则留之，陷下则灸之”的理论确定的两种不同的治疗原则和方法，是针刺治疗当中很重要的一个环节，针刺的补泻就是通过补泻手法来实现的。

《千金方》说：“凡用针之法，以补泻为先”。《灵枢·九针十二原》说“虚实之要，九针最妙，补泻之时，以针为之。”补泻是毫针刺法的核心内容。

补法：凡是能鼓舞人体正气，使低下的功能恢复旺盛的方法。泻法：凡是能疏泄病邪，使亢进的机能恢复正常的方法。针刺补泻都是通过针刺腧穴，激发经气来调节脏腑功能，促进阴阳平衡而恢复健康。

所谓经气，即经络之气。《灵枢·终始》说：“凡刺之道，气调而止。”可见针刺治病，关键在于调气。

大量临床实践和科学实验证明，针刺补泻效果的产生，主要取决于以下三个方面的因素：

（一）机体状态 人体在不同的病理状态下，针刺可产生不同的调节作用，即补泻效果。如当机体处于虚脱状态时，针刺可起到回阳固脱的作用；当机体处于实、热、闭证的情况下，针刺又可以起到泄热启闭的作用。如胃肠痉挛疼痛时，针刺可起到止痉而使疼痛缓解；胃肠蠕动缓慢而呈弛缓时，针刺可以增强胃肠蠕动而使其功能恢复正常。内因是事物发展变化的根据，针刺时 机体的状态是产生针刺补泻效应的主要因素。当然，针刺对机体的这种调节作用，又和机体正气的盛衰有着密切的关系。如机体正气旺盛，经气易于激发，针刺调节作用就显著；如果机体正气不足，经气不易激发，则针刺调节作用就较差。所以《灵枢·终始》说：“谷气至者，已补而实，已泻而虚。”

（二）腧穴特性 腧穴的功能不仅具有它的普遍性，而且有些腧穴具有相对的特异性。有些腧穴适宜于补虚，如足三里、关元等具有强壮作用，多用于补虚；而有些腧穴适宜于泻实，如少商、十宣等，具有泻邪作用，多用于泻实。

（三）针刺手法 针刺手法是促进人体内在因素转化的条件 是实现补虚泻实的重要环节。为了达到补泻的目的，进针以后， 往往需要配合运用一定的手法。古代医家在长期的医疗实践中， 创造和总结了很多针刺补泻手法。现将临床主要的几种针刺补泻手法介绍如下：

1. 提插补泻：

将针刺入穴位得气后，以提插时，针尖上下用力轻重和快慢，时间长短来进行补泻的一种方法。

补法：针刺得气后，先浅后深，重插轻提，提插的幅度小， 频率慢，操作时间短者。

泻法：针刺得气后，先深后浅，轻插重提，提插的幅度大， 频率快，操作时间长者。

2. 捻转补泻：

将针刺入穴位得气后，以针身左右旋转进行补泻的一种方法。

补法：针下得气后，捻转角度小，用力轻，频率慢，操作时间短者。

泻法：针下得气后，捻转角度大，用力重，频率快，操作时间长者。

此外，也有以左转时角度大，用力重者为补；右转时角度大，用力重者为泻。

3. 疾徐补泻：

将针刺入穴位得气后，以进出针的快慢（疾徐）为基础的一种补泻方法。

补法：进针时徐徐刺入，少捻转，疾速出针者。

泻法：进针时疾速刺入，多捻转，徐徐出针者（图220、221 ， 222）。



图220 徐疾补泻法①

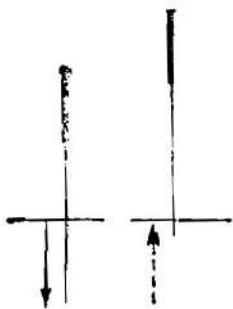


图221 徐疾补泻法②

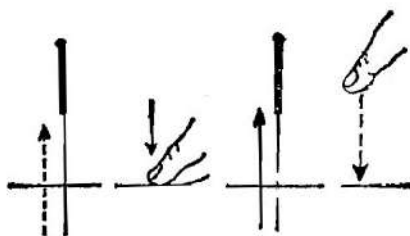


图 222 徐疾补泻法③

4. 开阖补泻:

是根据出针后，揉按针孔与否，依针孔的开闭为补泻的方法。

补法：出针后迅速揉按针孔。

泻法：出针时摇大针孔而不立即揉按。

5. 迎随补泻:

必须分辨经脉循行的顺逆与针刺的进针方向进行补泻的一种方法。

补法：进针时针尖随着经脉循行方向，顺经而刺。

泻法：进针时针尖逆着经脉循行方向，逆经而刺。

6. 呼吸补泻:

以进针、出针的时间，结合病人的呼吸分补泻的一种方法。

补法：当患者在呼气时将针刺入，吸气时出针。

泻法：当患者在吸气时将针刺入，呼气时出针。

7. 平补平泻:

进针得气后均匀地提插、捻转后即可出针。

以上各种手法，临床上可以相互配合使用。此外还有如下的复式手法：

1. 烧山火：

有补的作用，用于治疗寒证、虚证、阴证。《针灸大成》：“烧山火能除寒，三进一退热涌涌，鼻吸气一口呵五口。”又说：“烧山之火能除寒，一退三飞病自安，始是五分终一寸，三番出入慢提看。”

操作：将针刺入应刺深度的上1/3（天部），得气后行捻转补法，再将针刺入腧穴中1/3（人部），得气后行捻转补法，然后将针刺入腧穴下1/3（地部），得气后行捻转补法，即慢慢地将针提到上1/3，如此反复操作3次，即将针紧按至地部留针。在操作过程中，或配合呼吸补泻法中的补法，即为烧山火法（图223）。

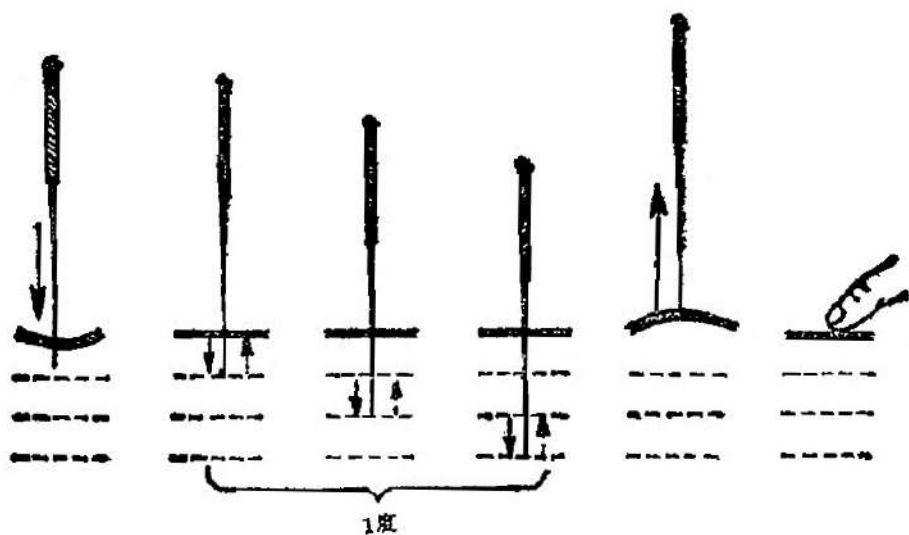


图 223 烧山火法

2. 透天凉：

有泻的作用，用于治疗热证、实证、阳证。《针灸大成》：“透天凉能除热，三退一进冷冰冰，口吸气一口，鼻出五口”。

操作：将针刺入腧穴应刺深度的下1/3（地部），得气后行转泻法，再将针紧提至中1/3（人部），得气后行捻转泻法，然后将针提至上1/3（天部），得气后行捻转泻法，将针缓慢地按至下1/3，如此反复操作3次，

将针紧提至上1/3即可留针。在操作过程中，或配合呼吸补泻法中的泻法，即为透天凉法（图 224）。

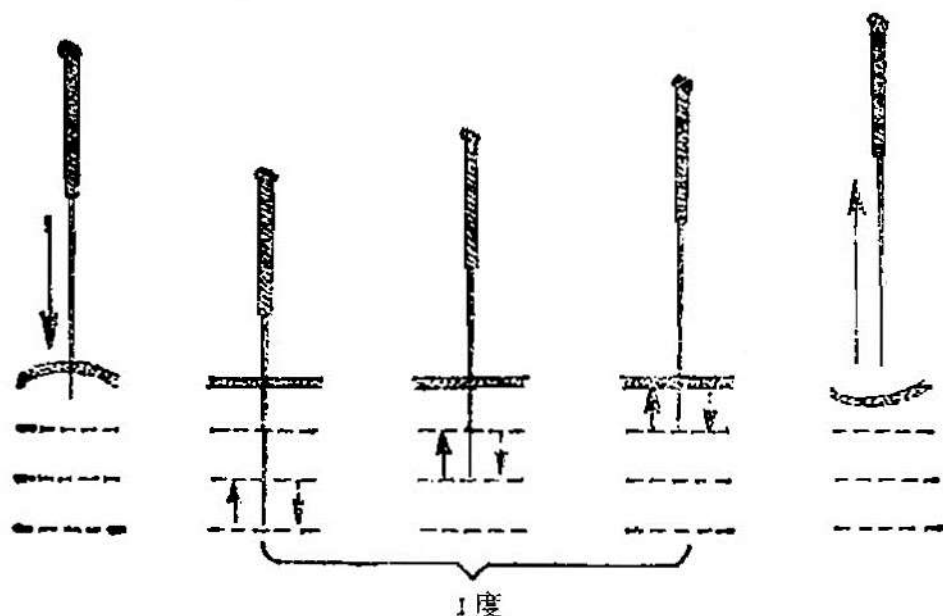


图 224 透天凉法

3. 阳中隐阴：

有先补后泻作用，用于治疗先寒后热，虚中夹实。《针灸大成》：“阳中隐阴，能治先寒后热，浅而深。”“阳中有个阴，先寒后热人，五分阳九数，一寸六阴行。”

操作：将针进入天部浅层，向左捻转九次，然后插入地部深层，向右捻针六次，提回天部浅层，以便重复操作如前。

4. 阴中隐阳：

有先泻后补作用，用于治疗先热后寒，实中夹虚。《针灸大成》：“阴中隐阳，能治先热后寒，深而浅。”

操作：将针进入地部深层，将针向右捻针六次，然后将针提至天部浅层，又向左捻九次，亦将针插入地部，以便重复操作。

五、留针与出针

(一)留针 将针刺入腧穴行针施术后，使针留置在穴内，以加强针感和针的持续作用，或者便于行针施术。留针与否和留针时间长短，应根据病情而定。一般的病症，针刺得气后，补泻操作完毕即可出针，或酌情留针10~20分钟，留针期间每隔几分钟要行针1次。但对一些特殊病症，如急性腰痛、破伤风、角弓反张、寒性、顽固性疼痛或痉挛性病症，可适当延长留针时间，有时留针可达数小时，以便在留针过程中作间歇性行针，以增强巩固疗效。若不得气时，留针还能起到候气作用。

(二)出针 在行针施术或留针后即可出针。出针时，左手持消毒棉球按住针孔周围皮肤，右手持针柄轻捻轻提，边捻边退到皮下，然后将针起出，并用消毒棉球按压针孔，防止出血。若用疾徐、开阖补泻时，则应按各自的操作要求，将针起出。《流注指微论》说：“出针贵缓，急则多伤。”但要保持针孔清洁，防止感染。出针后病人应休息片刻方可活动，医者应检查针数，防止遗漏。

〔临床应用〕

针刺效果的优劣，决定于针刺手法，因此临床必须掌握：

1. 针刺角度与深度：

根据全身不同部位的腧穴，病情需要以及患者的年龄、体形、体质等具体情况来决定针刺的角度和深度，以便达到治疗目的又不损伤脏器为原则。《素问·刺要论》说：“病有浮沉，刺有浅深。”《素问·调经论》又说：“病在脉调之血；病在血调之络；病在气调之卫；病在肉调之分肉；病在筋调之筋；病在骨调之骨。”指出邪气侵入机体后的病位不同，针刺治疗就应该有深有浅。欲使针感传入病区，就必须掌握针刺的角度和方向，只有针刺角度和深度适宜，才能达到预期的治疗效果。

2. 得气：

针刺之法，不论是补是泻，其关键是一个“气”字，气至而有效。在针刺当中怎样得气？首先就要明确诊断，确定属经。因经脉本身有“经脉所过，主治所在”的功能，同时又有所属脏腑和症候，所以临床必须运用以症定经，以经治病，只有把属经搞清楚，才能选穴准确，不失其经，才能激发失调的经气，使经气进入病所。其次是分清虚实，适当刺激。得气的快慢、强弱、除手法因素外，也取决于机体的强弱，疾病的虚实。针刺要根据不同体质，不同疾病，使刺激量与病、体相适应，才能激发经气，收到“气至而有效”的目的。

怎样控制针感？临床实践证明，针感的传导，有呈带状、有呈片状、有“专经”传、有伞状传，有的麻，有的木等。如果任其自然传导，就不能达到“气速效速”的目的。这就必须研究怎样控制针感，一般可按下述方法控制：

（1）深度适当，方向准确：根据穴位不同，采用适宜深度，以引起针感，《内经》说：“已入分肉之间，则谷气出”。掌握深度后，还要注意针刺方向，欲使针感传入病区，就必须使针刺方向斜向病所，达到“气至而有效”的效果。

（2）阻滞封闭，接经通气：针感多呈双向性传导，但欲使针感传入病所，可采用按截封闭法，即“欲气上行，按之在后，欲气下行，按之在前”。用关闭法，指力要强，刺手和押手配合要好，即可达到预期的目的。另外，还可以用接经通气的方法，它分首尾相接、沿经针刺，使经气通达全经。

（3）循经揉按，趋向病所：适用针下仅局部有针感，不向远处扩散，可通过沿经揉按、叩击，以帮助经气运行，使之趋向病所。

这都是保证针刺得气的关键，只有得气才能发挥针治作用。得气既可激发又可控制，得气的物质基础，可能是机体多种组织如血管、筋肉、神经、元神等功能参与下实现的。

3. 针刺补泻：

针刺的效果是通过补泻手法来实现的，而手法则是把穴位和疾病有机的联系起来。譬如说针刺合谷治疗牙痛，合谷是一个穴位，牙痛是一个病症，那么合谷穴怎么能治疗牙痛呢？只能用手法来实现，用补法还是用泻法。补泻手法在机体上是怎样起到治疗作用的呢？这是因为经脉在机体分布循行是有规律的，穴位在经脉线上是固定不变的，是气血集聚的部位。而针刺手法则是通过医生的操作，根据患者的机能状态，虚补实泻，因此手法是可变的。针刺效果就在于使不变的穴位，通过可变的手法（补或泻），来激发经气，活跃气血运行，从而达到调节机体的阴阳平衡，起到治疗疾病，预防疾病，强壮身体的作用。

补法要领：先进针提插到天部，留针不动以候气，然后分天、人、地三部提插捻转，每部行九阳数（提插9次，捻转9次），然后插针到天部，行随济卧针，留针5~10分钟，为1次操作法；如不出现热感，可同上反复进行2~3次；最后由上向下刮针9次，留针10呼，以消散针感，快出针，扞闭穴孔。《难经》说：“当补之时，从卫取气”，就是说针刺时先浅后深，向深部要快速重插，捻转指力要轻，顺着经气循行方向刺入，这样使针具占据了容纳经气的空隙，使经气受到“压力”，则必然使经气运行加快、活跃，温度亦随之上升，主观产生热感，达到热补的目的。

泻法要领：先进针提插3次到地部，留针不动以候气，然后分地、人、天三部提插捻转，每部行六阴数（提插6次，捻转6次）。然后提到天部，行迎夺卧针，留针5~10分钟，为1次操作法；如不出现凉感，可同上反复进行2~3次；最后由下向上刮针6次，留针10呼，以消散针感，慢提针，不闭穴孔。《难经》说：“当泻之时，从营置气”，就是说针刺时先深后浅，向浅部要快速猛提，捻转指力要重，逆着经脉方向刺入，这样必然使穴处造成一个空间，则可容纳更多的经气，使经气本身“膨胀”，结果经气则不活跃，温度亦随之下降，主观产生凉感，达到凉泻的目的。

除上述手法之外，在操作上要把揣、爪、搓、弹、摇、扞、循、捻等方法灵活的结合起来应用，是可以控制针感性质的。如要使麻感变成痠感，在操作上，押手要重按，提插幅度要小，速度要快，捻转角度要大；要使痠变成麻感，在操作上，押手要轻，提插幅度要大，速度要快，捻转角度要小。因痠和麻感分别是烧山火、透天凉的基础针感，痠感加上烧山火的手法操作即产生热感；麻感加上透天凉手法操作即产生凉感。这些操作方法，必须反复练习，因人而施，才能运用自如，提高针刺疗效。

复习思考题

1. 何谓刺手和押手？各有何作用？
 2. 常用的进针方法有哪几种？如何应用？
 3. 针刺得气的临床意义是什么？
 4. 何谓行针，得气，催气、候气？
 5. 行针基本手法和辅助手法有哪几种？
 6. 不得气的原因有哪些？对于不得气者应如何催气？
 7. 何谓补泻手法？常用的补泻手法有哪些？它们的操作方法如何？
 8. 何谓烧山火、透天凉针法？它们的操作方法如何？
- 何谓“阳中隐阴、阴中隐阳”针法？它们的操作方法如何？

第五节异常情况的处理及预防

针刺异常情况，是指在针刺过程中发生的特殊现象，如晕针、滞针、弯针、断针、创伤性气胸、血肿等。针刺治病虽然比较安全，但如操作不慎，疏忽大意，或犯刺禁，或针刺手法不当，或对人体解剖部位缺乏全面的了解，有时也会发生一些不应有的异常情况。如果一旦发生异常情况，医者一定要沉着、冷静，并要及时处理，一般不会造成严重后果。否则将会给患者带来不必要的痛苦，甚则危及生命。现将常见的针刺异常情况分述如下：

一、晕针

晕针是针刺过程中病人发生的晕厥现象。

原因：患者在施针时，精神过度紧张，体质虚弱，过度劳累，饥饿，大汗出，大泻后，大失血之后，体位不适以及医生在针刺时手法过重，而至针刺时或留针过程中而发此症。

症状：患者在针刺过程中，突然出现精神疲倦，头目眩晕，面色苍白，心慌气短，恶心欲吐，冷汗出，四肢厥冷，血压下降，脉象沉细或沉伏。严重者出现神志昏迷，卒然仆倒，唇甲青紫，二便失禁，脉微细欲绝。

处理：要立即停止针刺，并将已刺之针全部起出，使患者平卧，头部稍低，解开衣扣，并注意保暖，轻者静卧片刻，给以热茶或糖水饮之，即可恢复正常。重者在上述处理基础上，可刺水沟、素髻、内关、足三里、涌泉等穴，亦可灸百会、关元、气海等穴，即可恢复正常。若仍不省人事，呼吸微弱，脉细弱者，可考虑配合其他治疗或采用急救措施。

预防：根据晕针的原因予以预防。对于初次接受针刺治疗或精神过度紧张，身体虚弱者，应先做好解释工作，消除对针刺的顾虑，尽量采取卧位，取穴不宜多，手法不宜过重。对于饥饿、疲劳、大渴时，应待进食、休息、饮水后再予针刺；医生在针刺过程中，要精神专一，

随时注意观察病人的神色，询问病人的感觉，一旦有不适等晕针先兆，要及早采取处理措施，防患于未然。

二、滞针

滞针是指在行针时或留针后医者感觉针下涩滞，捻转、提插、出针均感困难而病人则感觉疼痛时，称为滞针。

原因：患者精神紧张，当针刺入穴位后，病人局部肌肉强烈收缩；或行针手法不当，向单一方向捻转，以致肌肉组织缠绕针体，或者病人施针后移动体位等而造成滞针。

现象：针在体内捻转不动，提插出针均困难，若强捻转或提插时，则病人感到剧痛。

处理：若患者精神紧张，局部肌肉强烈收缩时，嘱患者消除紧张状态，使局部肌肉松弛；因单向捻转而滞针者，则须反向捻转，使针松懈而出；因肌肉一时性痉挛，可留针一段时间，然后再行捻转出针，也可按揉局部，或在附近加刺一针，以宣散气血，缓解痉挛，随之将针取出；因体位移动引起的滞针，要恢复原来的体位，将针取出。

预防：对精神紧张者，应先做好解释工作，消除紧张和顾虑，行针时捻转角度不宜过大，更不能向单向连续捻转，针刺前选好体位。

三、弯针

弯针是指进针时或将针刺入穴位后，针身在体内形成弯曲，称为弯针。

原因：医者进针手法不熟练，用力过猛，或针下碰到坚硬组织，或在留针时因体位不适，或受到某种意外刺激而改变体位，或针柄受到外物碰压，以及滞针未得到及时正确处理，均可造成弯针。

现象：针体弯曲，针柄改变了进针时刺入的方向和角度，提插、捻转及出针时均感到困难，患者感觉疼痛。

处理：出现弯针后，即不得再行提插、捻转等手法。如针身轻度弯曲，可按一般起针方法将针慢慢退出；若针身弯度过大，应注意弯针的方向，顺着弯曲方向将针退出；若患者体位改变，则应使患者慢慢恢复原来体位，局部肌肉放松后，再将针缓缓起出。切忌强行拔针，以免将针断入体内。

预防：医者行针手法要熟练，指力要均匀；并要避免进针过速、过猛，选择适当体位，在留针过程中，嘱患者不要随意更动体位；针柄不得受外物碰撞和压迫；如有滞针时应及时处理。

四、折针

折针也称断针，是指针体折断在人体内。

原因：针具质量欠佳，针身和针根剥蚀损伤，针前失于检查，行针时强力提插、捻转，致使肌肉强烈收缩；或体位改变，外物碰压针柄处；或滞针、弯针未能及时正确处理，并强力拔针；或应用电针时突然加大电流强度等原因，均可导致折针。

现象：针身折断，残端留在体内，其残端可能露出皮肤面或者残端完全陷入皮肤之下。

处理：医者态度必须镇静，并嘱患者切勿更动原有体位，以防残端向肌肉深部陷入。若残端针体尚有部分露出皮肤外时，可用镊子钳出；若残端与皮肤相平或稍凹陷于体内者，可用左手拇、食二指垂直向下挤压针孔两旁，使残端露出体外，右手持镊子将针取出；若残端完全深入皮下或肌肉深层时，应在X线下定位取出。

预防：必须认真仔细检查针具，对不符合要求的针具要剔除不用，避免过猛、过强的行针。在行针或留针时，应嘱患者不要随意更换体位。针刺时更不宜将针身全部刺入腧穴，应留部分针身在体外，以便针根折断时取出。在进针或行针过程中，如发现弯针时，应立即出针，切不可强行刺入或行针。对于滞针、弯针应及时妥善处理，不可强行拔针。应用电针时，输出旋钮应该先置于“0”位，逐渐加大强度，切忌突然加大电流强度。

五、血肿

血肿是指针刺部位出现的皮下出血而引起的肿痛，称为血肿。

原因：针尖弯曲带钩，使皮肉受损或刺伤血管所致。

现象：出针后，针刺部位肿胀疼痛或继则皮肤呈现青紫色。

处理：若微量皮下出血而局部呈小块出血时，一般不必处理可自行消退。若局部肿胀疼痛较剧，青紫面积大而且影响到活动功能时，可先作冷敷止血后，再作热敷或在局部轻轻揉按，以促使局部瘀血消散吸收。

预防：仔细检查针具，熟悉解剖部位，避开血管针刺，出针时立即用消毒干棉球揉按压迫针孔。

六、刺伤脏器

1. 创伤性气胸：

胸背部及锁骨上窝、胸骨切迹上缘的腧穴针刺过深，会刺伤肺脏，使空气进入胸膜腔，发生创伤性气胸。此时患者突然感到胸痛、胸闷、心慌、呼吸不畅；严重者则有呼吸困难、心跳加快、紫绀、出汗、虚脱、血压下降等休克现象。检查患者时，叩诊呈过度反响，肺泡呼吸音明显降低或消失；严重者可发现气管向健侧移位，X线胸透检查。可进一步诊断，并观察气体多少和肺组织的受压情况。有的病例，针刺当时并无明显异常现象，隔几小时后，才逐渐出现胸痛、呼吸困难等症状，应注意观察。

为防止气胸的发生，医者针刺时精力必须集中，选好适当体位，根据病人体形的胖瘦，掌握进针的深度，提插幅度不要过大，胸背部的腧穴可采用斜刺、横刺，留针时间不宜过长一般少量的气体能自行吸收，如有咳嗽等症状，应予对症处理。但必须严密观察，如发现呼吸困难、紫绀、休克等现象。应立即抢救，如胸腔穿刺抽气减压、输氧、抗休克等。

2. 刺伤心、肝、脾、肾等内脏：

在心、肝、脾、肾等内脏相应的部位针刺过深，也会引起严重的后果。特别是对心脏扩大，或肝脾肿大的患者，尤须注意。

刺伤肝脾引起出血时，病人可有肝区或脾区疼痛，有时可向背部放散；如果出血不止，刺激腹膜时，可伴有腹痛、腹肌紧张，有腹部压痛及反跳痛等症状。刺伤肾脏时，有腰痛，肾区压痛及叩击痛，并有血尿出现；出血严重时并发生血压下降以致休克等全身症状。

损伤内脏，轻者卧床休息，一般能自愈，如果有出血征象时，应加强观察，注意病情及血压变化，用止血药或局部作冷敷止血。严重的损伤并有休克出现时，必须迅速急救处理。

其他脏器，如胆、膀胱、肠胃等在某些病态的情况下，如胆囊肿大、尿潴留、肠粘连时，也有刺伤的可能，都应予注意。

3. 刺伤脑、脊髓：

在项部正中的哑门、风府穴以及两旁的风池穴，颈1~2夹脊等穴进行针刺时，如果角度、方向、深度不适当，可以误伤延脑，引起严重后果。在背部正中线第一腰椎以上棘突间的穴位上针刺过深，可以刺中脊髓，出现触电样感觉向肢端放射，刺激过量也会发生后遗症。针刺这些部位的腧穴时，必须抱着高度负责的态度，随时注意针刺感应，切忌提插乱捣。如果刺伤血管，则可引起出血或血肿压迫症状。轻症注意观察，安静休息，渐能恢复，如针刺后出现头痛、恶心、呕吐等现象，甚则神志昏迷者，应及时抢救。

4. 刺伤神经干：

针刺在神经干和神经根部位的腧穴，出现电击样的放射感觉后，如再反复针刺，有可能损伤神经组织。由于神经损伤的程度不同，可引起受损神经的感觉或运动等功能障碍，某些病例还可出现灼性疼痛以及反射性肌肉痉挛或挛缩等现象。

〔临床应用〕

用针灸治疗疾病时，必须掌握针刺异常情况的原因、现象、处理、预防，这对防止针刺异常情况的发生是有重要意义的。医生如果能掌握针灸操作要领，在针刺操作过程中精神集中，认真负责，针刺异常情况是不会出现的。一旦发生异常情况，医生一定要沉着冷静，不惊慌就能及时妥善处理，否则将会给患者带来不必要的痛苦，甚则危及生命。

晕针就是在针刺过程中所发生的一种昏厥现象。一旦发生晕针要及时处理，不能拖延时间。晕针虽然无不良后果，但患者清醒后，一定要解释清楚产生晕针的原因。树立针灸治疗的信心。

滞针与弯针的产生，主要是没有掌握针刺要领，手法不熟练或体位选择不当造成的。所以初学者，一定要掌握针灸要领，加强针法练习。并要根据针刺腧穴选择好体位，滞针、弯针是可以避免的。

创伤性气胸的发生，主要是对人体解剖部位不熟悉，没有按划定的方向、角度、深度进行针刺造成的。所以要求针灸医生一定要掌握腧穴的局部解剖，操作要领，选择好体位和针具，根据患者的具体情况，针刺深度要适宜，异常情况是可以避免的。

复习唐考题

1. 常见的针刺异常情况有哪些？它们的临床表现和如何处理？
2. 试述晕针的原因，临床表现，处理方法和预防措施。
3. 怎样预防滞针和弯针？
4. 怎样预防折针？
5. 创伤性气胸发生的原因，临床表现及预防是什么？
6. 在什么情况下容易刺伤神经干？

第六节针刺的注意事项

在针刺过程中，为了防止针刺异常情况的发生，充分发挥针的治疗作用，还应注意以下几个方面：

1. 凡过于饥饿，过于疲劳，或精神过度紧张的患者，暂不预针刺。年老体弱刺激量不宜过强，并应采取卧位。
2. 对妇女怀孕三个月以下者，下腹部禁针；三个月以上者，上下腹部以及一些能引起子宫收缩的腧穴如合谷、三阴交、昆仑、至阴等均不宜针刺，月经期最好不针刺，但月经不正常为了调经，经期也可以针刺。
3. 小儿囟门未合时，头顶部腧穴不宜针刺，又因小儿不能配合，故不宜留针。
4. 针刺胸背部腧穴，针刺不宜过深，严防发生创伤性气胸等事故，对于脊髓、内脏和大血管附近的腧穴应注意针刺的角度、方向、深度。《素问·刺禁论》指出：“脏有要害，不可不察”。《素问·诊要经终论》也说：“凡刺胸腹者，必避五脏”。
5. 对皮肤有感染、溃疡、瘢痕或肿瘤的局部穴位不宜针刺。
6. 患者有出血性倾向的疾病，不宜针刺，如血友病、血小板减少症等。
7. 对尿潴留患者，在针刺少腹部腧穴时，也应掌握适当的针刺方向、角度、深度等，以免误伤膀胱等器官出现意外的事故。
8. 针刺眼区和项部的风池、风府、哑门等穴以及脊椎部的腧穴，要掌握一定的角度，更不宜大幅度提插、捻转和长时间的留针，以免伤及重要组织器官，产生严重的不良后果。

〔临床应用〕

针灸治疗疾病，具有安全、疗效可靠、副作用小等优点，但临床上必须掌握针刺注意事项。因为针刺注意事项把针刺时可能发生的针刺事故的主要内容总结出来，是针灸前辈的经验总结，在针灸临床治疗中必须遵循的。例如孕妇，因胎儿随月分增加而增长，所以腹部腧穴不

宜针刺；有些腧穴对子宫作用比较强，如合谷配三阴交，有使胎儿“应针而下”的说法，故孕妇不宜针刺。

复习思考题

1. 针刺注意事项包括哪些内容？
2. 妇女怀孕四个月以上，为什么全腹及腰骶部禁针？
3. 针刺眼区腧穴应注意什么？
4. 在什么情况下应慎针和忌针？

第二章 灸法 附:拔火罐疗法

- 第二章 灸法 附:拔火罐疗法

〔自学时数〕2学时

〔面授时数〕1学时

〔目的要求〕

1. 了解艾叶的功能及艾绒的制法。
2. 掌握艾炷灸、艾条灸、温针灸、温灸器灸，天灸、灯草灸，太乙神针、雷火神针的操作方法，适应范围和注意事项。
3. 掌握灸法的作用。
4. 熟悉施灸的程序及灸法的禁忌证。
5. 掌握拔火罐的操作方法，适应范围和注意事项。

灸法是借灸火的热力，给人体以温热性刺激，通过经络腧穴的作用，以达到治病防病的一种方法。《灵枢·官能》说：“针所不为，灸之所宜。”《医学入门》说：“药之不及，针之不到，必须灸之。”这说明它能治疗针刺效果较差的某些症，或结合针法应用，更能提高疗效，所以是针灸疗法中的一个重要组成部分。

第一节 灸用材料

施灸的原料很多，古今均以艾为主。艾为多年生草本，是菊科植物、叶似菊，表面深绿色，背面灰色有茸毛，性温芳香，五月采集，叶入药用。我国遍地皆产，以湖北蕲州产的艾为佳，叶厚而绒多，称为蕲艾。现将艾叶的功能及艾绒的制法分述如下：

艾叶的功能：在《名医别录》中记载：“艾叶苦，微温，无毒，主灸百病。”《本草从新》中说：“艾叶苦辛，生温，熟热，纯阳之性，能回垂绝之阳，通十二经，走三阴，理气血，逐寒湿，暖子宫，止诸血，温中开郁，调经安胎，……以之灸火，能透诸经，而除百病。”说明艾叶作为施灸材料，具有芳香开窍，通经活络，祛除寒湿，消肿散结，回阳救逆等作用。

艾绒的制法：在每年三月至五月间采集新鲜肥厚的艾叶曝晒干燥后，放入石臼中捣碎，筛去杂梗和泥砂。再晒再捣再筛，如此反复多次，即成淡黄色洁净软如棉的艾绒；或者利用机械反复压榨，使艾叶细碎，筛去杂质即成。艾叶以陈久易燃者为佳，故制成后应贮藏一定时期，才能用于临床。

〔临床应用〕

施灸的热源，自古至今是以艾绒为主的。因为艾绒具有易燃而不焰，又不易熄灭，火力温和，其热力能透组织深部的特性，患者亦少有痛苦的特点。为什么要用陈久的艾绒进行施灸呢？因陈艾绒燃烧缓慢，火力温和，烟少，燃烧后艾灰不易脱落等。而新艾含挥发油多，燃烧快，火力强，烟雾大，艾灰易脱落灼伤皮肤。故《孟子·离娄》说：“七年之病，求三年之艾”

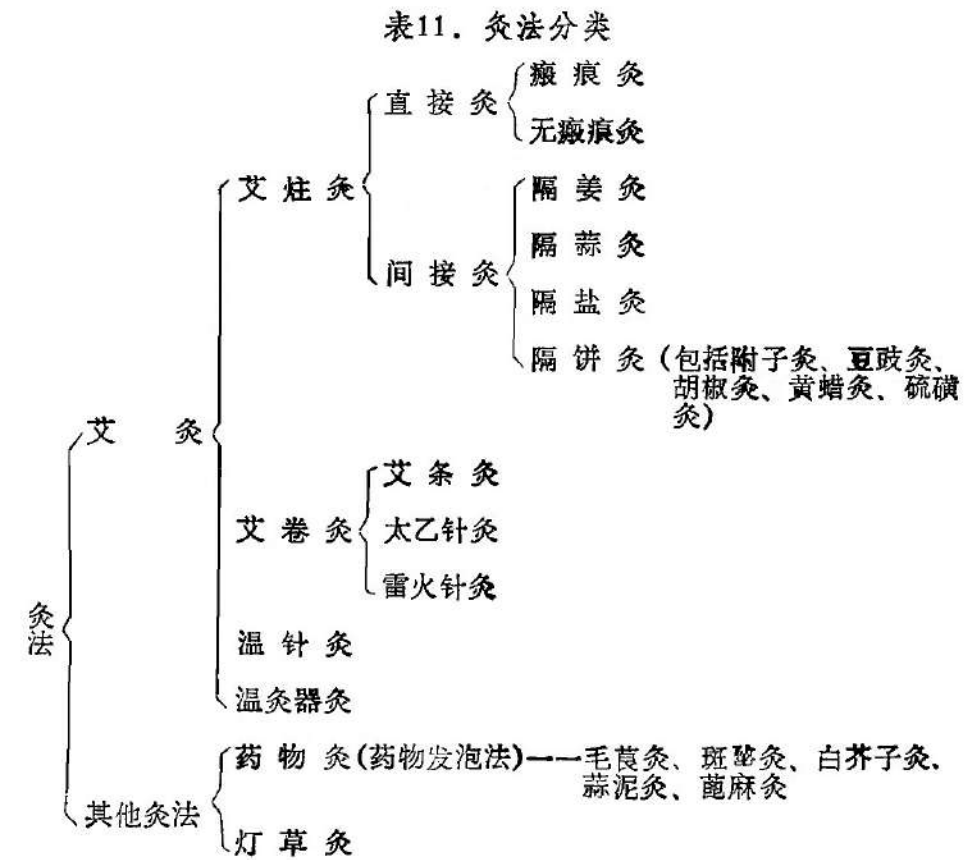
艾绒必须保存在通风干燥的容器内，防止发霉，一旦发霉就失去艾绒的特性。因艾绒除含氮有机物，碳氢化合物，灰之外，还含有挥发油、苦艾醇、苦艾酮，维生素甲、乙、丙、丁，腺素，胆素等，有兴奋中枢神经的作用。如果艾绒的这些成分被破坏，再用施灸，疗效就会降低，所以艾绒一定要保藏好，才能更好的发挥艾绒的作用。

复习思考题

1. 艾叶有什么功能？
2. 施灸时为什么选陈艾？
3. 艾绒有哪些优点？

第二节 灸法的分类及其操作

灸法治疗疾病，已有悠久的历史。先是单纯的艾灸，后来衍化为多种灸法。大体上可分为艾炷灸、艾条灸、温针灸、温灸器灸和药物灸（药物发泡法）等几类。各类灸法如表11。



一、艾炷灸

艾炷灸包括直接灸和间接灸，是灸法的主体。古代的灸法多指直接灸，间接灸是后来发展起来的一种疗法。

艾炷是将纯艾绒用手指搓捏成圆锥体。又称艾团、艾丸、艾圆等。艾炷分为大、中、小三种类型。小艾炷是把艾绒搓紧，捻成麦粒状或上尖下大的圆锥体；中艾炷是搓成象半个黄豆粒或半个杏核大的上尖下大的锥体；大艾炷是搓成蚕豆大者的上尖下大的圆锥体（图225）。

一般规定炷底直径为0.8厘米，高1厘米，重量为0.1克，燃烧时间为3~5分钟。这是为了科学研究和临床准确而设的。施灸多少？以“壮”计数，壮，是以青壮年为标准的意思。燃烧一枚艾炷即为一壮。施灸的壮数是因人、因病、因穴而异，少则一壮，多则数百壮，一般灸3~7壮即可。

(一) 直接灸 是将艾炷直接放在皮肤上施灸（图226）。可分为瘢痕灸和无瘢痕灸。

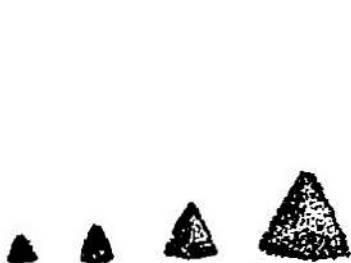


图 225 艾炷

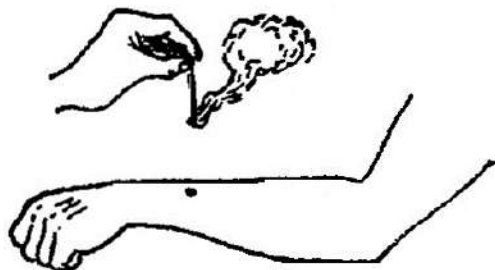


图 226 直接灸

1. 瘢痕灸：又称化脓灸、着肤灸、打脓灸。施灸前用大蒜捣汁，涂敷施灸部位以增加粘附和刺激作用，然后放置中艾炷施灸。每壮艾炷必须燃尽，除去灰烬后，方可继续加炷施灸，一般施灸5~10壮。因施灸时艾火烧灼皮肤疼痛较剧，可用手在施灸部位周围轻轻拍打，借以缓解疼痛。在正常情况下，灸后一周左右施灸部位化脓形成灸疮，5~6周左右灸疮自行痊愈，结痂脱落，留下瘢痕。临床上用于慢性、顽固性疾病。如哮喘、肺癆、瘰癧、慢性胃肠病等证。

2. 无瘢痕灸：又称非化脓灸。将施灸部位涂敷凡士林油，以增加粘附作用，再放上艾炷点燃，当艾炷燃剩2/5左右，患者感到烫时即用镊子将艾炷夹去，更换艾炷再灸，连续灸3~7壮。以局部皮肤充血、红晕为度。因灸后不化脓，也不留有瘢痕，易为患者所接受。本法适用于虚寒性疾病，小儿各种虚弱病证。如腹痛、腹泻、胃脘痛、腰痛、阳痿、痛经等症。

(二) 间接灸 又称隔物灸、间隔灸。在施灸时于皮肤和艾炷之间垫上不同的药物，称为间接灸。由于间隔的药物不同，可分为隔姜灸、隔蒜灸、隔盐灸、隔饼灸等。

1. 隔姜灸：皮肤和艾炷之间隔上姜片，即为隔姜灸。

用鲜姜切成直径大约2—3厘米，厚约0.2~0.3厘米的薄片，片上用针刺数孔，置于施术部位或腧穴上，再将大艾炷放在姜片上点燃施灸（图227），当艾炷燃尽，再移炷施灸，灸3~7壮，以局部皮肤红润不起泡、患者有舒适感为度。适用于虚寒证。呕吐、腹痛、腹泻、遗精、风寒痹痛如等。



图 227 隔姜灸



图 228 隔盐灸

2. 隔蒜灸：皮肤和艾炷之间隔上蒜片，即为隔蒜灸。

用独头大蒜切成约0.2~0.3厘米厚的薄片，片上用针刺数孔，施灸法同隔姜灸。适用于外科痈疽疮毒，肺癆、瘰癧、腹中积块等。

3. 隔盐灸：皮肤和艾炷之间隔上细盐即为隔盐灸。

用于脐窝部施灸。将纯净细盐填敷于脐孔，将脐孔填平，或于盐上再置一薄片姜，上置大艾炷施灸（图228）。待患者感到灼痛时则换艾炷再灸，连续施灸，至证候改善为止。适用于中风脱证，急性腹痛，吐泻，痢疾，四肢厥冷等证。

4. 隔饼灸：皮肤和艾炷之间隔上药饼，即为隔饼灸。根据病情需要，所选用的药饼不同，有不同的名称。

(1) 附子饼灸：皮肤和艾炷之间隔上附子饼，即为附子饼灸。

将附子压成粉末，以黄酒调和做成直径约3厘米、厚约0.2~0.3厘米的附子饼，饼上以针刺数孔，放置施术部位或腧穴上，上置大艾炷施灸，灸数壮，以患者有温热舒适感为度。适用

于各种阳虚证。如外科中的疮毒窦道盲管，久不收口，或既不消散又不化脓的阴性虚性外证等，有祛腐生肌作用；还可用于命门火衰而致的阳萎、早泄，有温肾壮阳作用。

(2) 豆豉饼灸：皮肤和艾炷之间隔上豆豉饼，即为豆豉饼灸。

将豆豉压成粉末，用黄酒调和，制成疮口大的饼，厚约0.2~0.3厘米，饼上用针刺数孔，置于疮面上，上置大艾炷施灸，以患者感到温热舒适为度。适用于外科的痈疽发背，溃后久不收口，疮色黑暗者，每日灸1次，直到疮口愈合为止，有散泄毒邪的作用。

(3) 胡椒饼灸：皮肤和艾炷之间隔上胡椒饼，即为胡椒饼灸。

将白胡椒压成粉末，用水调面粉作饼，厚约0.2厘米，中央按成凹陷，内置入丁香散（丁香、肉桂、麝香）上置大艾炷灸之，使患者感到温热为宜。适用于风湿痹痛及局部麻木不仁等病。有温经散寒，通经止痛作用。

(4) 黄蜡灸：据《医宗金鉴》记载：“黄蜡灸法，可治痈疽发背，恶疮顽疮。先以湿面随肿根作圈，高寸余，实贴皮上，如井口形，圈内铺蜡屑三、四分厚，次以铜漏杓盛桑木炭火，悬蜡上烘之，令蜡溶化至沸，再添蜡屑，随溶随添，以井满为度。皮不痛者毒浅，灸至觉痛为度；皮痛者毒深，灸至不痛为度。然后去火杓，即喷冷水少许于蜡上，俟冷起蜡，蜡底之色青黑，此毒出之征也。如慢肿无头者，以湿纸试之，于先干处灸之，初起者一、二次即消，已成者二、三次即溃。疮久溃不敛，四围顽硬者，即于疮口上灸之，蜡从口入，愈深愈妙，其顽腐瘀脓尽化，收敛甚速。”

(5) 硫磺灸：据《东医宝鉴》记载，此法可治诸疮久不瘥，变成痿管者。方法是：取硫磺一块，如疮口大小，安置疮上，另取少许硫磺，于火上烧之，用叉尖挑起，点硫磺令著，如此三、五遍，以脓水干瘥为度。因硫磺性温有毒，有温阳杀虫之效，所以用之灸治痿管，可收良效。

二、艾卷灸

包括艾条灸、太乙针灸和雷火针灸。

(一) 艾条灸 是取纯艾绒24克，平铺在26厘米长，20厘米宽、质地柔软疏松而又坚韧的桑皮纸上，将其卷成直径约1.5厘米的圆柱形，越紧越好，用胶水或浆糊封口而成(图229)。也有在每条艾绒中掺入肉桂、干姜、丁香、独活、细辛、白芷、雄黄、苍术、没药、乳香、川椒各等分的细末6克，则成为药条。施灸的方法分温和灸、雀啄灸、熨热灸三种方法。

1. 温和灸：将艾条的一端点燃，对准施灸部位，约距2~3厘米左右进行熏烤(图230)，使患者局部有温热感而无灼痛，一般每处灸3~5分钟，至皮肤稍起红晕为度。对于昏厥、局部知觉减退的患者和小儿，医者可将食、中二指，置于施灸部位两侧，这样可以通过医者手指的感觉来测知患者局部受热程度，以便随时调节施灸距离，掌握施灸时间，防止烫伤。适用于风寒湿痹等证。

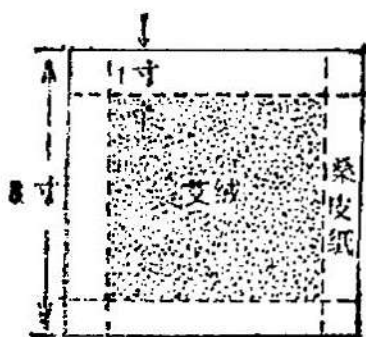


图 229 艾条制做法



图 230 温和灸

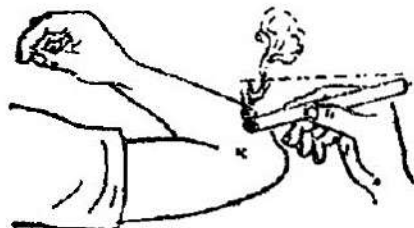


图 231 雀啄灸

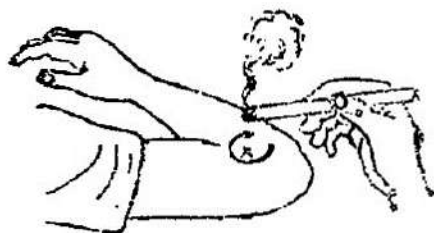


图 232 熨热灸

2.雀啄灸：将艾条的一端燃着，与施灸部位的皮肤并不固定在一定距离，而是象雀啄食一样，一上一下活动施灸（图231）。适用于小儿疾病、胎位不正、无乳等证。

3.熨热灸：将艾条燃着的一端，与施灸部位的皮肤约距离3厘米左右，如熨衣服一样，来回旋转移动进行施灸（图232）。适用于面积较大的风湿痛、软组织损伤等。

（二）太乙针灸 是以纯艾绒和太乙针灸处方中的药物制成。

制针法：人参125克、穿山甲250克、山羊血90克、千年健500克、钻地风300克、肉桂500克、小茴香500克、苍术500克、甘草1000克、防风2000克、麝香少许，共为细末，取药

末24克掺入艾绒内，平铺在40厘米见方的桑皮纸上，紧卷成爆竹状，外用鸡蛋清封固，阴干后备用。

用法：施灸时，将太乙针的一端烧着，用布七层包裹其烧着的一端，立即紧按于应灸的腧穴或患处，进行灸熨，针冷再燃再灸熨，如此反复灸熨7~10次为度。适用于风寒湿痹，顽麻、痿弱无力、半身不遂等以及腹痛，泻泄。

（三）雷火针灸 其制作方法与太乙针基本相同，惟药物处方有异。

制针法：用纯净的艾绒150克；沉香、木香、乳香、茵陈、羌活、干姜、穿山甲各9克，共为细末，麝香少许。取棉皮纸二方，一方平置桌上，一方双折重复于上，然后将药料与艾绒和匀，铺于纸上，卷成爆竹状，外涂鸡蛋清，以桑皮纸厚糊六、七层，阴干勿令泄气。

用法：取两支，先燃一支，将烧红的一端紧裹于数层布中，按于应灸的部位或穴上，如雀啄样随按随提。待针热消失后，即另换一支，反复施灸，使热感及药气透入组织，直至灸处红润为止。适用于筋骨疼痛，经络不通，沉寒积冷等证。

三、温针灸

温针灸又称针上加灸、传热灸、烧针尾。是针刺与艾灸结合使用的一种方法。适用于既需留针，又需施灸的疾病。操作方法是，针刺得气后，并给予适当补泻手法而留针时，将纯净艾绒捏裹在针柄上，或用艾条一段长约2厘米左右，插在针柄上，点燃施灸（图233）。待艾绒或艾条烧完后除去灰烬，将针取出。本法适应证比较广，如虚寒性病症，腰脊、关节、肢体冷痛，胃腹冷痛，经闭，痛经等。

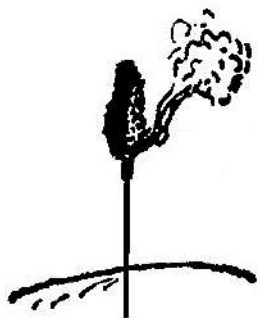


图 233 温针灸

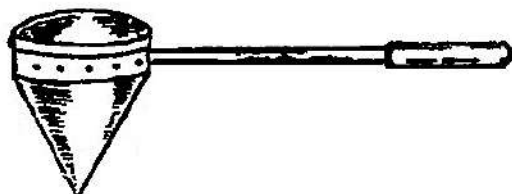


图 234 温灸器

四、温灸器灸

温灸器灸，又称灸疗器灸、温筒灸。是一种用特制的金属温灸器而施灸的方法。

器具：温灸器的样式有多种，一般是用金属片特制成的，分内外两层，都有数十小孔，内层装艾绒，外层是保护层。市场有出售。（图234）

操作方法：使用温灸器时，先将艾草或加参药末放入小筒内燃着后，将温灸器扣盖好，然后在拟灸的腧穴部位上来回熨烫，使局部发红为度。有调和气血、温中散寒的作用。适用于妇人小儿及惧怕灸者，可用于治疗寒性腰痛、腹痛、关节痛等。

五、药物灸

药物灸，又称天灸、自灸。近代又称为发泡疗法。是用对皮肤有刺激性药物敷贴于穴位或患部，使局部充血、起泡有如灸疮，故称药物灸。如毛茛灸、斑蝥灸、白芥子灸、蒜泥灸、蓖麻子灸等，介绍如下：

（一）毛茛灸 毛茛灸是将草乌头的嫩苗，采取其叶子揉烂，敷贴于皮肤。初感局部热辣、充血，轻时即发生水泡。一般3~4天后自行愈合。愈合后局部呈现色素沉着，逐渐消退。敷贴在内关、大椎穴时，可治疗疟疾，寒痹可贴于局部。

(二) 斑蝥灸 斑蝥是一种甲虫，含斑蝥素，对皮肤有较强的刺激作用。用时研成末，用甘油调和敷贴于皮肤，发泡作用很强，用于治疗面瘫、癣等。

(三) 白芥子灸 白芥子含挥发油，对皮肤有刺激作用。用时研末水调，发泡效果显著，用于治疗关节疼痛等。或调和其它药物，如白芥子50克，延胡索50克，细辛、甘遂各25克，共为细末，加麝香少许，调匀，调敷肺俞、膏肓、百劳等穴治疗哮喘。

(四) 蒜泥灸 大蒜含精油，对皮肤有刺激作用。用时把大蒜捣成泥，敷贴皮肤能起。如贴鱼际穴处，使之发泡，可治疗喉痹；贴合谷穴处发泡，可治疗扁桃腺炎等。

(五) 蓖麻子灸 把蓖麻子去外壳，捣烂如泥备用。敷贴于百会穴治疗子宫脱垂、脱肛，敷贴于涌泉穴处治疗滞产等。

六灯草灸

灯草灸又称灯火灸。用灯心草一根，以麻油浸之，燃着后，于应灸的腧穴上爆之。功能疏风解表，行气化痰，清神止搐。多用于治疗小儿脐风，疳腮和胃痛，腹痛，痧胀等症。

〔临床应用〕

应用灸法治疗疾病，必须掌握各类灸法的操作及运用。如癰疽灸，在操作时为什么要用蒜汁贴艾炷？主要原因是大蒜内含精油，对皮肤有刺激作用，有发泡和消毒作用，减少感染机会。癰疽灸已达到三度烧伤，灸后要保护局部清洁，以防感染，灸后要贴上淡水膏（樟丹50克，麻油300克熬膏备用），再用消毒敷料保护。化脓期每天要多换几次淡水膏，防止脓汁排泄不畅。由于本法灸后成三度烧伤，患者极为痛苦，要用此法治疗时，必须征得患者的同意，否则中途不合作，造成失败。癰疽灸虽然疼痛，却属于良性刺激，能改善体质，增强抗病能力，从而达到防病治病的目的。

非癰疽灸在操作时为什么要用凡士林油贴艾炷？这是因为非癰疽灸不须烧伤，只要达到皮肤红润为度，凡士林油没有发泡作用，故用之。在操作时一定要不要烧伤皮肤，特别是面部，否则影响美观。

间接灸，必须根据不同的病证选择不同的隔物，在操作中，只更换艾炷不更换隔物，将预

定施灸的壮数灸完为止。

温针灸，在操作时一定要把艾炷或艾条的一段在针柄固定牢，并嘱病人不要变动体位，防止燃着的艾炷或艾段脱落，烧伤皮肤或衣物。为了防止烧伤，也可用5厘米的正方形的硬纸片，纸片中间扎一孔套在针体上，覆盖在穴位的皮肤上，起到保护作用。

药物灸，一定要掌握药物的剂量，用量过大后引起中毒，或者给患者造成不应有的痛苦。

****复习思考题****

1.何谓艾灸疗法？主要分哪些类别？

2.概述艾炷灸、艾卷灸的操作方法及其适应证。

3.何谓温针疗法？其操作方法怎样？

4.常用的间接灸法有哪些？

5.常用的药物灸法有哪些？

6.艾炷分几种？标准艾炷是指什么说的？

第三节灸法的作用

灸法是一种温热刺激，对虚寒证效果好。《灵枢·官能》说：“阴阳皆虚，火自当之；……经陷下者，火自当之；结络坚紧，火所治之。”

《灵枢·经脉》又说：“陷下则灸之。”《灵枢·禁服》又说：“陷下者，脉血结于中，中有著血，血寒，故宜灸之”。说明灸法能治疗很多疾病，其作用如下：

1. 艾灸有温补中气、回阳固脱的作用，故用治疗久泄，久痢，遗尿，崩漏，脱肛，阴挺及寒厥等。
2. 艾灸有温经通络、祛湿散寒的作用，故用治疗风、寒、湿邪为患的病证及气血虚弱引起的眩晕，乳少，闭经等。
3. 艾灸有行气活血、消瘀散结的作用，用于治疗乳痈初起，瘰疬、疔肿未化脓者，也有一定疗效。
4. 预防疾病，保健强身，常灸大椎、关元、气海、足三里等 腧穴，能鼓舞人体正气，增强抗病能力。《千金方》说：“凡宦游吴蜀，体上常须三两处灸之，勿令疮暂瘥，则瘴疠、温疟、毒气不能着人。”
《扁鹊心书》说：“人于无病时，常灸关元、气海、命门、中脘，虽未得长生，亦可保百余年寿矣。”
5. 隔姜灸有解表散寒、温中止呕的作用，可用于外感表证及虚寒性呕吐、泄泻、腹痛、痹证等。
6. 隔蒜灸有清热、解毒、杀虫的作用，可用于疔肿疮疡，毒虫咬伤，对哮喘，脐风，肺癆，瘰疬等也有一定的疗效。
7. 隔盐灸有温中散寒、扶阳固脱的作用，可用于虚寒性呕吐、泄泻、腹痛、虚脱，产后血晕等。
8. 附子饼灸有温肾壮阳的作用，可用于命门火衰而致的遗精、阳痿、早泄或疮疡久溃不敛等。

〔临床应用〕

在临床上应用灸法治病，要掌握灸法的作用，根据灸法的不同作用，采用不同的灸疗方法，才能有效的治疗各种不同的疾病。如隔姜灸、隔蒜灸、隔盐灸、附子饼灸各有不同作用及适应证。但灸法治病也不是万能的，只有对证才能取效。

复习思考题

1. 灸法有哪些作用？
2. 隔姜灸、隔蒜灸的作用及适应证有什么不同？
3. 隔盐灸、附子饼灸的适应证各有什么区别？

第四节 灸法的注意事项

一、点穴与体位

施灸时，取穴的正确与否将直接影响灸法的治疗效果。所以在施灸前必须选好体位，再进行取穴。《千金方》：“凡点灸法，皆须平直，四体毋使倾侧。灸时孔穴不正，无益于事，徒破皮肉耳。若坐点则坐灸之，卧点则卧灸之，立点则立灸之，反此亦不得其穴矣。”《明堂灸经》：“须得身体平直，勿令蜷缩，坐点勿令俯仰，立点勿令倾侧。”说明施灸时不但要取穴准确，还须嘱咐患者不可移动体位。因为体位的变换，可以使腧穴因骨骼、肌肉的牵拉而改变位置，必然会影响取穴的准确性。此外，还须注意的是体位必须平直，将拟施灸的腧穴暴露出来并使腧穴面朝上，以防艾炷安放不平正，燃烧时火力不能集中，热力不能深透肌肤，而致减低疗效；同时也可防止施灸时艾炷滚下，烫伤皮肤，给病人造成不必要的痛苦。

二、施灸的程序

施灸的程序是先灸上部，后灸下部；先灸背部，后灸腹部；先灸头身，后灸四肢。《千金翼方》说：“凡灸法先发于上，后发于下；先发于阳，后发于阴。”《明堂灸经》说：“先灸上，后灸下；先灸少，后灸多。”灸的顺序虽说如此，但还须结合病情来考虑，因病制宜，灵活掌握，不可拘泥。

三、施灸剂量的大小

直接灸，是以小艾炷或中艾炷为主；间接灸，是以中艾炷或大艾炷为主。而且要依患者的体质、病情、部位来考虑灸量的大小。《医宗金鉴》说：“凡灸诸病，必火足气到，始能求愈。然头与四肢皮肉浅薄，若并灸之，恐肌骨气血难堪，必分日灸之，或隔日灸之，艾炷宜小，壮数宜少。有病必当灸巨阙、鸠尾者，必不可过三壮，艾炷如小麦，恐火气伤心也。背腰以下皮肉深厚，艾炷宜大，壮数宜多，使火气到，始能去痼冷之疾也。”《千金方》说：“头面目咽，灸之最欲

生少；手臂四肢，灸之须小熟，亦不宜多；胸背腹灸之尤宜大熟，其腰脊欲须少生。”《外台秘要》说：“凡灸有生熟，候人盛衰及老小也。衰老者少灸，盛壮强实者多灸。”所谓“生”是指少灸；“熟”是指多灸。上述记载是说明施灸的标准。一般的说，凡是新病、体质强壮的艾炷宜大，壮数宜多；久病、体质虚弱者艾炷宜小，壮数宜少。从部位来说，胸部不宜用大艾炷；四肢末端，皮肉浅薄处不可多灸；腹背部及肌肉丰厚处则可多灸。妇女儿童，艾炷宜小，壮年则可大。古代文献中有灸百壮者，都是指多次灸治的累积数。其它灸法的施灸量，可参考艾炷灸法。艾条法、温灸器灸一般以时间计算。太乙针、雷火针则以熨灸的次数计算。

四、灸疮的处理

在施灸过程中，因施灸过量，时间过长，局部出现水泡，不要擦破，可任其自然吸收；如果出现较大水泡，可用消毒针具刺破水泡，放出液体，再涂以龙胆紫；化脓灸者，灸疮化脓期间，一个月内勿做重体力劳动，疮面局部勿用手搔。为了保护痂皮，要防止摩擦，疮面宜保持清洁，以防感染，可敷贴淡水膏，根据脓汁分泌的多少，每日换药1~2次，用消毒敷料复盖。

五、灸法的禁忌

1. 病情的禁忌：由于灸法属于温热刺激，而热能伤阴，故阴虚阳亢和邪热内炽的病症皆不可灸。如阴虚癆瘵，咯血吐血，心悸怔忡，多梦遗尿，中风闭证，高热神昏等。如热病而误用灸法，致损阴血，助益有余之阳；甚则火毒内攻而成坏病。
2. 部位禁忌：凡颜面、眼区、重要脏器、血管浅在部位、筋腱所在部位，以及妇女妊娠期的少腹部、腰尻部、乳头、阴部事、均不宜施灸。
3. 穴位的禁忌：头维、人迎、哑门、睛明、攒竹等穴，均不宜灸。但据《针灸大成》记载有45穴、《针灸集成》试载有53穴禁灸。古人所记，仅供参考。

六、灸法的补泻

灸法同刺法一样，也有补泻的区分。《灵枢·背俞》：“以火补者，毋吹其火，须自灭也；以火泻者，疾吹其火，传其艾，须其火灭也。”

朱丹溪解释说：“灸法有补泻火，若补火，艾灭至肉；若泻火，不要至肉，便扫除之，用口吹之，风主散故也。”《针灸大成》也说：

“以火补者，毋吹其火，待自灭，即按其穴；以火泻者，速吹其火，开其穴也。”这说明补法的施灸，须艾火自灭，使火力缓缓透入深层，故能补虚扶羸，温阳起陷；泻法的施灸，须用口吹，使火速燃，不燃至皮肉即便扫除，力促而短，目的在于起消散作用。

〔临床应用〕

在施灸时一定要熟悉施灸的注意事项，才能提高灸治的疗效，防止灸疮的发生（化脓灸除外）。因此，施灸的体位要舒适、持久，操作时的穴位要平稳，这样就能达到取穴准确、平稳，防止艾炷脱落。施灸程序是使施灸处不遗漏灸点。施灸剂量的大小，是灸法治疗中很重要的环节，如果灸量不够，达不到治疗效果，如果灸量过大，又会发生灸疮或坏病。所以要根据病情、体质、年龄、部位给以恰当的施灸量，中病即止。灸法的禁忌，古代文献记载颇多，有些有一定道理，有些是不必要的。应从临床实际出发，不可拘泥。

复习思考题

1. 施灸的程序是什么？
2. 灸法的禁忌证是什么？
3. 灸疮如何处理？
4. 《灵枢·背俞》篇中是怎样谈灸法的补泻的？
5. 灸法能否用于治疗实证、热证？为什么？试谈谈你的看法？

〔附〕拔罐法

拔罐法是以罐为工具，利用燃烧热力排除罐内空气，造成负压，使罐吸附于腧穴或应施术的部位，产生温热刺激并造成皮肤充血、瘀血现象的一种疗法。最早见于《肘后方》，以牛角制罐，作外科吸脓血之用，故又称角法和吸筒法。随着医疗实践的不断发展，罐的质料大为改进，使用方法有所发展，治疗范围有所扩大，不仅用于外科，也用于内科的一部分病证。拔罐法常和针灸疗法配合使用，其作用与灸法有相似之处。

1. 罐的种类：

罐的种类很多，临床常用的有以下几种：

(1) 竹罐：用直径3~5厘米坚固无损的竹子，制成6~10厘米长的腰鼓形的圆筒，一端留节做底，另一端做罐口，打磨光滑平正。它的优点是取材容易，经济易制，轻巧，不易摔碎。缺点容易燥裂、漏气、吸附力不大。

(2) 陶罐：是由陶土烧制而成，有大有小，罐口平正光滑，肚大而圆，口、底较小，其状如腰鼓。它的优点是吸着力大，缺点是质量易摔碎、损坏。

(3) 玻璃罐：形如球状，罐口平滑而宽，有大、中、小三种不同型号。它的优点是质地透明，使用时可以窥测罐内皮肤的充血、瘀血程度，便于随时掌握情况，缺点是容易摔碎、损坏。

(4) 抽气罐：用青、链霉素药瓶，将瓶底切去磨平，切口须光洁，瓶口的橡皮塞须保留完整，便于拔气时用。近年已发展成电动抽气吸罐。

2. 操作方法：

拔罐的操作方法分以下几种：

(1) 火罐的操作法：用燃烧时火焰的热力排除罐内空气，使罐内呈负压，将罐吸着在皮肤上。有以下几种方法：

投火法：将小纸条点燃后、投入罐内，然后速将罐罩在施术部位（图235）。此法适用于侧面横拔，否则，会因燃烧物落下而烧伤皮肤。

闪火法：用镊子或止血钳子挟住酒精棉球，点燃后在火罐内壁中段绕1~3圈后，迅速退出，然后将罐罩在施术部位（图236）。此法比较安全，不受体位限制，是较常用的拔罐方法。

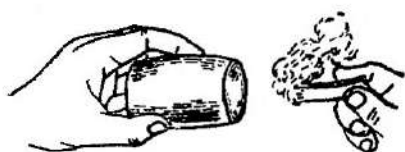


图 235 投火拔罐法

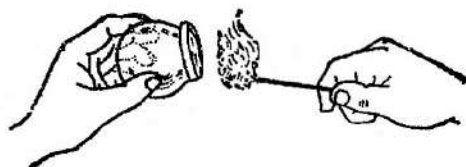


图 236 闪火拔罐法



图 237 贴棉拔罐法

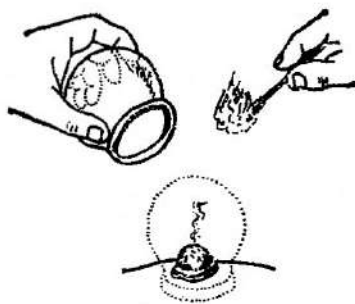


图 238 架火拔罐法

贴棉法：用一平方厘米的棉花片，不要太厚，略浸95%酒精，贴在罐内壁的上、中段，以火柴点燃，罩在施术部位上(图237)。此法多用横位拔罐。

架火法：用2~3平方厘米不易燃烧的块状物作支架，上置95%的酒精棉球，点燃后把罐罩上。此法去罩罐要准确，不要碰掉燃烧的棉球，以防烧伤皮肤，适用于平卧位（图238）。

（2）水罐操作方法：一般用于竹罐。先将竹罐放在锅内加水煮沸，用镊子倒挟竹罐的底端，甩去罐内的沸水，并用折迭的冷毛巾紧扣罐口。乘热按在施术部位，即能吸住。适用任何部位的拔罐。

3. 各种拔罐法的运用：

（1）单罐：用于较小范围病变或压痛点。可按病变的或压痛的范围大小，选用适当口径的火罐。如胃病可在中院穴拔罐，岗上肌肌腱炎在肩髃穴处拔罐等。

（2）多罐：用于病变范围比较广泛的疾病。可按病变部位的解剖形态等情况，酌量吸拔数个乃至十数个。如某一肌束劳损时可按肌束的位置成行排列吸拔多个罐，称为排罐法。治疗某些内脏或器官的瘀血时，可按脏器的解剖部位的范围在相应的体表部位纵横并列吸拔几个罐子。

（3）闪罐：罐子拔上后，立即起下，如此反复多次地拔住起下，起下拔住，至皮肤潮红为止，多用于局部皮肤麻木、疼痛或功能减退等疾患，如面瘫等。

（4）留罐：拔罐后，留置一定的时间，一般留置5~15分钟。罐大吸着力强的应当减少留罐时间，肌肤薄处留罐时间不宜过长，以免损伤皮肤。

（5）推罐：又称走罐、飞罐。一般用于面积较大、肌肉丰厚的部位，如腰背、大腿等。选用口径较大的罐子，罐口要求平滑，最好用玻璃罐，先在罐口涂一些滑润油脂将罐子吸上后，以双手握住罐底，即后边着力，前边略起来，慢慢向前推动，这样在皮肤表面上下或左右来回推拉移动数次，至皮肤潮红为度（图239）。

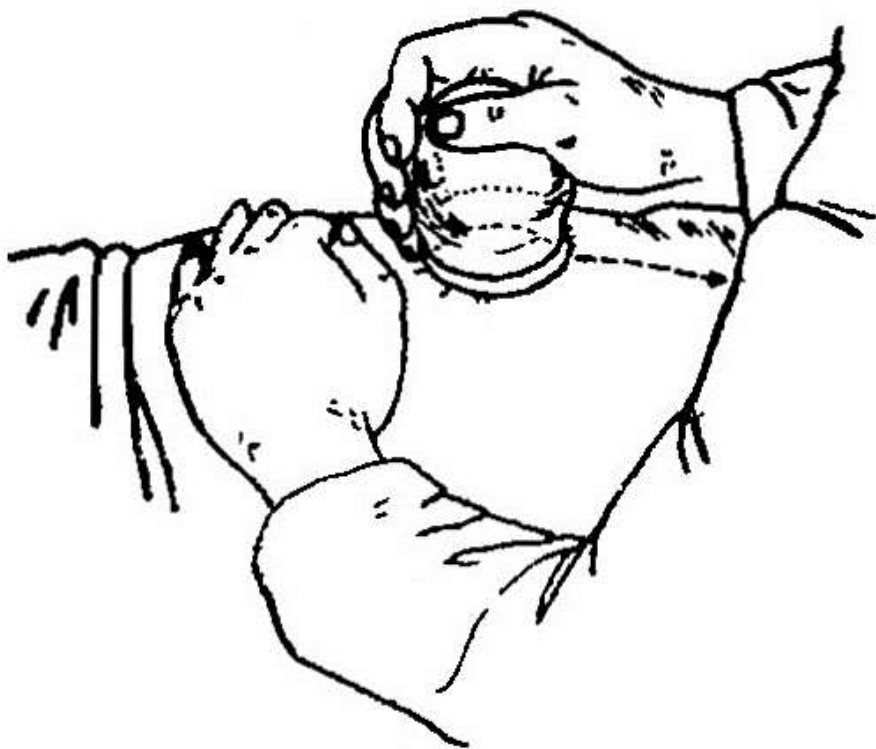


图 239 推罐法

(6) 药罐：常用的药罐有两种：煮药罐：将配制成的药物装入布袋内，扎紧袋口，放入清水煮沸至适当浓度，再把竹罐投入药液内煮15分钟。使用时，按水罐法吸拔在应拔的部位上，多用于风湿痛等病。

常用药物处方：麻黄、蕲艾、羌活、活独、防风、秦艽、木瓜、川椒、生乌头、蔓陀罗花、刘寄奴、乳香、没药各6克。

贮药罐：在抽气罐内事先盛贮药液（约为罐子的 $\frac{2}{3}$ ~ $\frac{1}{2}$ ）。常用的药液为辣椒水、两面针酊、生姜汁、风湿酒等。然后按抽气罐操作法，抽去空气，使罐吸在皮肤上。也有在玻璃罐内盛贮 $\frac{1}{3}$ ~ $\frac{1}{4}$ 的药液，然后用火罐法吸拔在皮肤上。常用于风湿痛，哮喘，咳嗽，感冒，溃疡病，慢性胃炎，消化不良，牛皮癣等。

（7）针罐：先在一定部位施行针刺，待达到一定的刺激量后，将针留在原处，并以针刺处为中心，拔上火罐。如果与药罐结合，称为针药罐，多用于风湿病。

（8）刺血（刺络）拔罐：用三棱针、粗毫针、皮肤针等，先按病变部位的大小和出血要求，按刺血法刺破出血，然后拔上火罐，可以加强刺血法的效果。适用各种急性、慢性软组织损伤，神经性皮炎，皮肤瘙痒，丹毒，神经衰弱，胃肠神经官能症等。

4. 适应范围：

拔罐法有温经通络、祛湿逐寒、行气活血、消肿止痛的作用。临床多用于以下几个方面：

风湿痹痛：如肩痛、背痛、腰腿痛、落枕等。均可在痛处拔罐。

胃肠疾病：胃痛，腹痛，呕吐，腹泻等。可在腹部及背部拔罐。

肺部疾病：如哮喘，咳嗽等。可在背部拔罐。

刺络拔罐：适用于急性扭伤有瘀血者，疮疡和部分皮肤病，如丹毒，神经性皮炎等。可在患处拔罐。

5. 注意事项

（1）患者要取舒适体位，应根据不同部位，选择不同口径的火罐，注意选择肌肉丰满，富有弹性，没有毛发和骨骼凸凹的部位，防止罐脱落。

（2）皮肤有溃疡、过敏、水肿及大血管部位，不宜拔罐；孕妇的腹部和腰骶部，也不宜拔罐。

（3）有自发性出血和损伤后出血不止的患者，不宜使用拔罐法。

（4）起罐时手法要轻巧而缓慢，以一手抵住罐边皮肤，按压一下，使气漏入，罐子即能脱下，不可硬拉或旋动。

(5) 拔火罐时应注意勿灼伤或烫伤皮肤。如出现烫伤、水泡，小的可不必处理，任其自然吸收；如水泡较大或皮肤有破损，先用消毒针具刺破水泡，或用注射器抽出水液，然后涂龙胆紫并以纱布包敷，防止感染。

〔临床应用〕

拔罐法是一种物理疗法，是使罐内空气因热而膨胀逸出，当罐口紧贴皮肤时，罐内温度下降，空气稀薄而产生负压，吸力增强，皮肤因被吸吮而高起，毛细血管扩张，局部充血，通过机体的调整功能，以疏通气血，宣泄风寒湿邪，从而直接改善局部状态，而达到治病目的。

拔罐应根据不同部位，选用大小合适的罐。应用投火法拔罐时，火焰须旺，动作要快，使罐口向上倾斜，避免火原落下烫伤皮肤。应用闪火法时，棉花棒蘸95%酒精不要过多，以防酒精滴下烧伤皮肤。用贴棉法时，须防止燃着棉花脱下。用架火法时，扣罩要准确，不要把燃着火架撞翻。用煮水罐时，应甩去罐中的沸水、以免烫伤病人的皮肤。

拔罐时，体位不要变动，防止罐脱落；经拔罐后，局部有瘀血未消退时，不要在原处拔罐。

复习思考题

1. 什么叫拔罐疗法？常用的火罐有哪几种？
2. 闪火法、投火法拔罐如何操作？
3. 拔罐法的适应范围是什么？
4. 试述拔罐法的注意事项。
5. 拔罐疗法为什么能治病？

第三章其他针法

- 第三章其他针法

第一节三棱针

〔自学时数〕1学时

〔目的要求〕

掌握三棱针的操作方法，适应范围和注意事项。

三棱针是由古代九针中的锋针发展而来的，古称锋针。针长约2寸，是一种针柄粗而圆、针身呈三棱形、针尖锋利的针具（图240）。一般应用于刺络放血。《素问·针解》说：“菀陈则除之者，出恶血也。”《灵枢·官针》也说：“络刺者，刺小络之血脉也。”络脉壅滞、血瘀不通的疾病，在人体特定部位的浅表血管，放出少量血液，达到治疗目的。

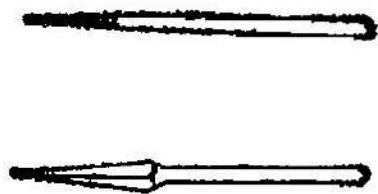


图 240 三棱针

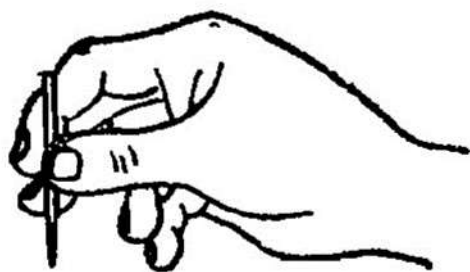


图 241 三棱针持法

一、操作方法

右手拇、食两指持住针柄，中指扶住针尖部，露出针尖1~2分许，以控制针刺深浅度，针刺时左手捏住指（趾）部，或夹持、舒张皮肤，右手持三棱针针刺（图241）。常用的刺法有以下几种：

1. 缓刺：适用于肘窝、腘窝浅静脉放血。如曲泽、委中等穴，先用橡皮带在应刺穴位上端束扎，医者用右手持三棱针对准穴位或静脉胫起处，刺入1~2分，然后将针退出，待黑色血出尽变为红赤色，可将橡皮带解开，用消毒棉球揉按针孔。

2. 点刺：又称速刺。适用于四肢末梢穴位或表浅静脉浅刺放血。用左手拇指、食指和中指捏紧应刺的部位或腧穴、右手持三棱针迅速刺入1~2分，立即退针，然后用手挤压局部，使之出血。

3. 挑刺：又称挑针疗法。适用于腧穴或反应点的挑刺。是以左手按压施术部位的两侧，使皮肤固定，右手持针，将腧穴或反应点的表皮挑破，深入皮内，将针身倾斜并轻轻地提起，挑断部分纤维组织，然后局部消毒，覆盖敷料。

4. 散刺：又称围刺。适用于病灶周围，如癰、丹毒等。在病灶周围用三棱针由外向内点刺数针，然后用两手轻轻挤压或者用火罐吸拔，使恶血出尽，以消肿痛（图242）。

二、适用范围

三棱针是在放血泻络时使用，故有活血消肿，开窍泄热，通经活络的作用，适用实证和热证。现就临床常见病症及其放血部位介绍如表12。

表12. 常见病症放血部位表

病症	放血部位	刺法	备注
发热	大椎、十宣、委中、曲泽	点刺	
中暑	水沟、十宣、委中	点刺	
吐泻	十二井、曲泽、委中	点刺	
中风闭症	十二井、水沟	点刺	
头痛	太阳、印堂	点刺	
疟疾	大椎、陶道、后溪	点刺	
腰痛	委中	缓刺	

病症	放血部位	刺法	备注
热痹	委中、曲泽	缓刺	
肢端麻木	十宣	点刺	
丹毒	局部及周围、尺泽、委中	散刺、缓刺	尺泽、委中缓刺
风癣	耳后静脉、局部	点刺、散刺	局部散刺
酒皴鼻	素髻及两侧变赤处、尺泽	散刺、缓刺	尺泽缓刺
湿疹	委中	缓刺	
痔疮	上唇内侧、及与上齿龈交界处	挑刺	挑粟粒样小疙瘩
急惊风	攒竹、水沟、十宣、督脉沿线	点刺	
疳积	四缝	点刺	
暴发火眼	耳尖	点刺	
喉痹	少商、商阳	点刺	
口疮	患处周围	散刺	
发际疮	背部小红疙瘩、委中	点刺、缓刺	委中缓刺

三、注意事项

1. 注意无菌操作，以防感染。
2. 点刺放血时，宜轻、宜浅、宜快，出血不宜过多。勿刺伤深部动静脉。
3. 气血两亏的虚证及常有自发性出血或损伤后出血不止的患者，不宜使用。

〔临床应用〕

使用三棱针进行治疗时，首先要对针刺部位进行严密消毒， 并要检查针具是否锋利，刺入1~2分深，以出血为度。出血时不要按其针孔，任其血流，最初是紫色，待变鲜红色为度，一般不要超过10毫升。最后用干棉球揉按擦净针孔即可。根据不同病症可采用缓刺、点刺、挑刺、散刺等方法进行放血。

复习思考题

1. 三棱针有几种操作方法？如何进行操作？
2. 三棱针的适应范围是什么？
3. 应用三棱针时应注意什么？

第二节皮肤针

〔自学时数〕1学时

〔目的要求〕

掌握皮肤针的操作方法，适应范围和注意事项

皮肤针又名梅花针、七星针、是用5或7枚不锈钢针，集束固定在针柄的一端而成，用它在一定部位皮肤上进行叩打，以疏通经络，调节脏腑之气，而治疗疾病。《灵枢·官针》：“半刺者，浅内而疾发针，无针伤肉，如拔毛状。”“扬刺者，正内一，傍内四而浮之，以治寒气之博大者也。”“毛刺者，刺浮痹皮肤也。”皮肤针是半刺、扬刺、毛刺等针法的发展。

一、操作方法

针具和施术部位常规消毒，针具可在75%酒精中浸泡30分钟。用右手握针柄，以无名指、小指将针柄末端固定于小鱼际处，一般针柄末端露出手掌后2~3厘米，以拇、中二指夹持针柄，食指置于针柄中段上面（图243）。用腕力进行弹刺，使针尖垂直叩打在皮肤上，并立即弹起，反复进行。

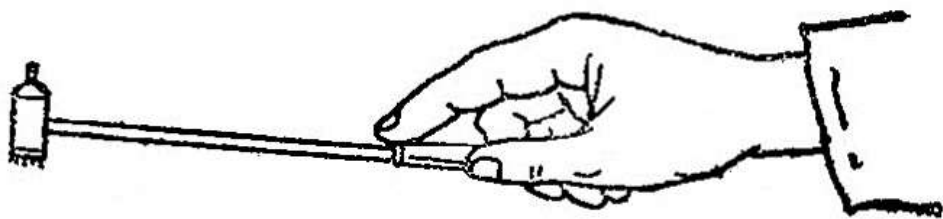


图 243 皮肤针的持针法

叩刺分轻刺、重刺和中等刺激法三种：

轻刺激：叩刺时用力小，针尖接触皮肤时间越短越好，使局部皮肤潮红、充血即可。

重刺激：叩刺时用力稍大，针尖接触皮肤时间稍长，使叩刺的部位皮肤微出血为度。

中等刺激：叩刺时用力介于轻刺激，重刺激之间，使叩刺部位皮肤呈潮红，有丘疹，但不出血为度。

二、刺激部位

皮肤针的刺激部位比较广泛，大体可分为三类：

1. 常规刺激部位：一般均以背部脊柱侧为主，并按不同疾病配用其他相应部位。
2. 局部刺激部位：在病区及四周有关炎位进行叩刺，或环形叩刺。
3. 重点刺激部位：在脊柱两侧异常反应点（敏感点、条索状物、结节等）进行反复重点叩刺。

三、适应范围

一般疾病均可应用。在临床多用于不寐，头痛，胸胁痛，斑秃，高血压，神经性皮炎，近视，口眼喎斜等。

1. 不寐：重点叩刺脊柱两侧，心俞、肝俞及手少阴心经、手厥阴心包经。失眠，多梦，心悸加风池、三阴交穴或其附近的敏感部位。
2. 头痛、偏头痛：重点叩刺后项部、头部。头痛可取后头、项部以及疼痛部位和远端有关经脉循行线上的敏感部位；偏头痛可取后项部，痛侧头部和有关经脉循行的敏感部位。
3. 胸痛、胁痛：重点叩刺第1～12胸椎两侧，特别是膈俞、肝俞处。胸痛可按疼痛部位及其上下沿肋骨走行叩刺；胁痛除上述重点部位外，可配合支沟、太冲穴。
4. 斑秃：重点叩刺后项、脱发区、腰、骶部、太渊、内关，阳性物处。兼头痛、口干，心烦加刺胸椎8～10两侧及风池。心悸多梦，失眠加刺胸椎5～7两侧及神门、大椎。

5. 高血压：重点叩刺后项部、腰骶部，以及阳性物处、风池、曲池、足三里。
6. 神经性皮炎：重点叩刺后项部，骶部和患部、阳性物处。
7. 近视：重点叩刺后项部、眼区、颞部。在叩打时可在太阳、攒竹、四白、风池多叩刺几针。
8. 口眼喎斜：重点叩刺颜面局部，以攒竹、瞳子髎、地仓、颊车部为主，并配合合谷或敏感点。
9. 痛经：重点叩刺腰骶两侧和任脉、肾经循行位。重点叩刺气海、关元，配合用肝俞、三阴交。
10. 瘰癧：重点叩刺部位为第5～10胸椎两侧，并配合在瘰癧周围重刺。

四、注意事项

1. 针尖要平齐、无钩，叩刺时针尖必须垂直而下、以减少疼痛。针柄与针头联结处必须牢固，以防叩刺时滑动。
2. 针具及叩刺部位的皮肤应消毒，叩刺后的局部皮肤，如有出血者，应进行清洁及消毒，以防感染。
3. 局部皮肤有外伤及溃疡者，不宜使用皮肤针叩刺。
4. 应用皮肤针治疗时，出现晕针现象，处理同体针。

〔临床应用〕

皮肤针治疗疾病，虽然不限于腧穴，也不是单纯“以痛为腧”。而是祖国医学整体观作为理论依据的。《素问·皮部论》指出：“凡十二经络脉者，皮之部也。是故百病之始生也，必先于皮毛。”说明十二皮部同十二经脉、十二脏腑有密切关系。应用皮肤针叩击皮部，可疏通经络脏腑之气，从而起到调整机体的作用。

皮肤针在操作时，持针不要过紧或过松，如果握针太紧会使腕关节肌肉紧张，影响操作；如果握针太松，会使针身左右摆动，造成疼痛或出

血。叩打皮肤针时速度要均匀，防止快慢不一，用力不匀地乱刺。针尖起落要垂真，即将针垂直刺下，垂直提起，如此反复操作。针刺部位要准确，按预定应刺部位下针，针与针之间的距离要相等，一般针距在1~1.5厘米左右。

叩刺的部位：脊柱两侧，由上而下，左右各打三行，椎体叩刺棘突间；头部呈网状叩刺；胸部沿肋缘叩刺；腹部按“井”字叩刺；四肢按三阴三阳经脉进行叩刺；各关节、口、眼、耳按耳环形叩刺。

叩刺的强度，要根据患者体质、年龄、病情以及叩击部位的不同，而分为轻刺激、中刺激、重刺激三种强度，临床时选择应用。

复习思考题

1. 皮肤针如何操作？能治疗哪些疾病？
2. 使用皮肤针治病时应注意什么？
3. 皮肤针为什么能治病？
4. 皮肤针的刺激部位大体可分几类？

第三节皮内针

〔自学时数〕1学时

〔目的要求〕

掌握皮内针的操作方法，适应范围和注意事项。

皮内针是以特制的小型针具固定腧穴的皮下或皮内，进行时间较长埋藏，达到防治疾病一种方法。

一、皮内针具

皮内针是用30~32号不锈钢丝制成图钉型和麦粒型两种不同形状的针具(图224)。由于较长时间留针，所以又称埋针。



图 244 圆钉型和
麦粒型皮内针

1. 图钉型皮内针：又称掀针型皮内针。针身长约0.2~0.3厘米，针柄呈环形，针身与针柄呈垂直状。
2. 麦粒型皮内针：又称颗粒型皮内针。一般针身长约1~1.5厘米，针柄形似麦粒，针身与针柄呈一直线。

二、操作方法

1. 图钉型皮内针：多用于面部和耳部腧穴埋针。局部常规消毒后，用小镊子夹住针柄，针尖对准选定的腧穴，轻轻垂直刺入，使环状的针柄平整的留在皮肤上，然后以小方形胶布贴敷固定。

2. 麦粒型皮内针：可用于人体大部分腧穴。用左手拇、食二指按压腧穴的上下皮肤，固定穴位，右手用小镊子夹住针柄，对准穴位沿皮刺入0.5~1.0厘米左右，针柄留于皮肤外，用胶布将留于皮肤外的针身和针柄固定，再用较大的方形胶布把埋入皮肤内的针身和皮肤外部分覆盖上，以防止针具因活动而退出和汗水浸入针孔，发生感染。

埋针时间的长短，要根据病情而定。一般以2~3天为宜，秋冬季节可埋6~7天，暑热天埋针不宜超过2天，以防止感染。埋针期间，每隔4小时左右，用手按压埋针处1~2分钟，以加强刺激，增强疗效。

三、适应范围

埋针多用于顽固性疼痛疾病，久治不愈的慢性病症。如头痛胃脘痛，胆结石，胆绞痛，哮喘，不寐，高血压，面肌痉挛，遗尿，月经不调，痛经，痹症等。

四、注意事项

1. 不要在关节处埋针，以免活动时产生疼痛或折针。
2. 皮肤有化脓性炎症或破溃处，不宜埋针。
3. 埋针期间，注意清洁，避免针孔处着水。暑热天出汗较多，埋针时间不宜过长，以防感染。
4. 埋针后，患者感觉疼痛，或妨碍肢体活动时，应将针取，重新埋置。

〔临床应用〕

皮内针是从九针中的毫针演变而成，本于《素问·离合真邪论》：“静以久留”的刺法。选穴时，一定要选择易固定而又不妨碍肢体活动的部位，更不应该在关节部位埋针。用胶布固定时，一定要用小块胶布固定针柄，再用适当的大块胶布固定埋针部位，以防针具因活动而退出。若进针时，皮下出血，该处就不宜留针，防止因针继续刺激该处，造成出血不止或血肿。埋针时或埋针后患者出现疼痛，或妨碍肢体活动时，应将针改变针刺方向重埋或另选其它腧穴再埋。

复习思考题

1. 皮内针有几种？如何操作？
2. 皮内针的适应范围是什么？
3. 应用皮内针时应注意什么？

第四节 火针

〔自学时数〕1学时

〔目的要求〕

掌握火针的操作方法，适应范围和注意事项。

火针是用特制的粗针，烧红后刺入一定部位或腧穴以治疗疾病的一种方法。《灵枢·官针》说：“焮刺者，刺燔针取痹也。”明·吴鹤皋说：“焮针者，用火先赤其针而后刺，此治寒痹之在骨也”。《千金方》说：“外疔痈疽，针惟令极熟。”火针不但能治疗痹证及疮疖，痈疽，也可治疗各科中的一些病症。

一、针具

火针的针体较粗，多用不锈钢制成。针柄多用竹或骨质包裹，以避免烫手。也有应用特制的针具，如弹簧式火针、三头火针以及用钨合金所制的火针等。弹簧式火针进针迅速并易于掌握针刺深度，三头火针常用于对体表痣、疣的治疗（图245）。钨合金制成的火针，在炽热时弹性好，便于临床应用。

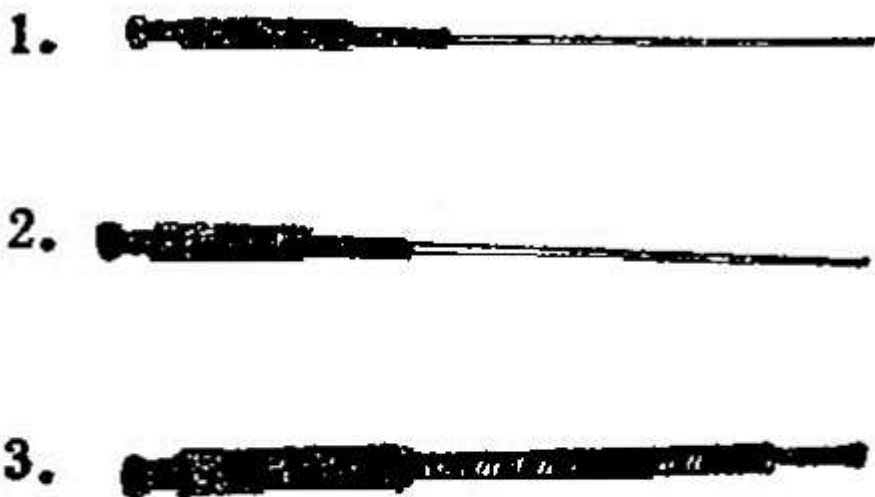


图 245 火针针具

1. 细火针 2. 粗火针
3. 三头火针

二、操作方法

1. 选穴与消毒：火针选穴与毫针选穴的基本规律相同，根据病症不同而辨证取穴。先用碘酒消毒局部，后用酒精棉球脱碘。

2. 烧针方法：《针灸大成·火针》说：“灯上烧，令通红，用方有功。若不红，不能去病，反损于人。”目前临床多用酒精灯烧针、必须把针烧红，才能使用。近年电火针也有应用。

3. 针刺与深度：针刺时，用烧红的针具，迅速刺入选定穴位内，即迅速拔出。关于针刺的深度要根据病情、体质、年龄和针刺部位而定。四肢、腰腹针刺稍深，可刺2~5分；胸背部穴位针刺宜浅，可刺1~2分。外科疾患如痈疽、瘰癧、血丝虫病象皮腿等可深刺些，风湿痛、顽癣、肌肤冷麻等可浅刺些，顽癣亦可用三头火针浅刺。

三、适应范围

火针具有温经通络，祛风散寒，化腐软坚的作用。主要用痹证，胃下垂，胃脘痛，泄泻，阳萎，瘰癧，风疹，月经不调，痛经，小儿疳积，顽癣，肌鞘囊肿，血丝虫病象皮腿，痈疽，扁平疣，痣等。

四、注意事项

1. 使用火针时，必须细心慎重，动作敏捷、准确。
2. 使用火针时要避开血管、肌腱、神经干及内脏器官。面部除治疣和痣外，不用火针。
3. 火针刺激强烈，体质虚弱者及孕妇慎用或不用。
4. 发热的病症，不宜用火针治疗。
5. 施行火针后，要保护针孔，不能搔抓和洗浴，以防感染。深刺后，要用消毒纱布敷贴，用胶布固定1~2天，以保护针孔，防止感染。

〔临床应用〕

应用火针治疗疾病时，手法一定要熟练，动作要敏捷，准确掌握进针的深度、角度、方向，才能达到应刺的深度和部位。一般针具的针身长3~4寸，也有1~1.5寸的，直径为0.5~1毫米，针柄一般用竹子或骨质制成，可免烫手。治疗顽癣时，可用三头火针，针刺要浅，针距要均匀而疏松，可免发生刺脱皮肤等。

复习思考题

1. 火针操作有几种方法？如何应用？
2. 火针的适应范围是什么？
3. 应用火针治疗时应注意什么？

第五节电针

〔自学时数〕2学时

〔目的要求〕

掌握电针的操作方法，适应范围和注意事项。

电针是在针上通以微量电流，用以防治疾病的一种方法。广泛应用于临床及针刺麻醉。

一、电针器的选择

电针器的种类很多，目前较常见的有蜂鸣式电针器，电子管电针器，半导体电针器等多种。它采用振荡发生器，输出接近人体生物电的低频脉冲电流，即可作为电针，又可用点状电极或板状电极直接放在穴位或患部进行治疗。电针器以具有刺激量大，安全，可用干电池，不受电源限制，耗电量少，体积又少，携带方便，耐震，无噪声者为佳。

二、操作方法

毫针刺入腧穴得气并施行补泻手法，把电针器上的输出电位器调至“0”值，将一对输出导线分别接在两根针的针柄上，然后打开电源开关，选择需要的波型和频率，逐渐调高输出电流至所需的电流强度，使患者出现能耐受的痠麻感。电针治疗中，人体经过多次刺激后，会产生适应性，刺激感由强变弱。此时，应加大刺激量或改变频率，以保持恒定作用。每次通电时间，一般为10~20分钟。治疗完毕，把电位器调到“0”值，关闭电源，然后撤去导线，退出毫针。

三、脉冲电流的作用和电针的适应证

脉冲电流的作用：人体组织是由水分、无机盐和带电生物胶体组成的复杂的电解质电导体。当一种波型、频率不断变换的脉冲电流作用人体时，组织中的离子会发生定向运动，消除细胞膜极化状态，使离子

浓度和分布发生显著变化，从而影响人体组织功能。离子浓度和分布的改变，是脉冲电流治疗作用最基本的电生理基础。低频脉冲电流通过毫针刺刺激腧穴，具有调整人体功能，加强止痛、镇静，促进气血循环，调整肌张力等作用。

低频脉冲电流的波形、频率不同，其作用亦不同。频率有每分钟几十次至每秒钟几百次不等。频率快的叫密波（或叫高频），一般在50~100次/秒，频率慢的叫疏波（或叫低频），一般是2~5次/秒。有的电针器有连续波（亦叫可调波），可用频率旋钮任意选择疏密波形。有的电针器分别装置密波、疏波、疏密波、断续波等数种波形，临床使用时应根据病情选择适当波形，可以提高疗效。

密波：能降低神经应激功能。先对感觉神经起抑制作用，接着对运动神经也产生抑制作用。常用于止痛、镇静，缓解肌肉和血管痉挛，针刺麻醉等。

疏波：其刺激作用较强，能引起肌肉收缩，提高肌肉韧带的张力。对感觉和运动神经的抑制发生较迟。常用于治疗痿症，各种肌肉、关节、韧带、肌腱的损伤等。

疏密波：是疏波、密波自动交替出现的一种波形。疏密交替持续的时间约备1.5秒，能克服单一波形易产生适应的缺点。动力作用较大，治疗时兴奋效应占优势。能促进代谢，促进气血循环，改善组织营养，消除炎性水肿。常用于止痛，治疗扭挫伤，关节周围炎，气血运行障碍，坐骨神经痛，面瘫，肌无力，局部冻伤等。

断续波：是有节律的时断、时续自动出现的一种疏波。断时，在1.5秒时间内无脉冲电输出，续时，是密波连续工作1.5秒。断续波形，机体不易产生适应，其动力作用颇强。能提高肌肉组织的兴奋性，对横纹肌有良好的刺激收缩作用。常用于治疗痿症，瘫痪，也可用作电肌体操训练。

锯齿波：是脉冲波幅按锯齿形自动改变的起伏波，每分钟16~20次或20~25次，其频率接近人体的呼吸规律，故可用于刺激膈神经（相当于天鼎穴部）作人工电动呼吸，抢救呼吸衰竭（心脏尚有微弱跳动者）

故又称呼吸波。并有提高神经肌肉兴奋性，调整经络功能，改善气血循环等作用。

2. 电针的适应证：凡毫针治疗有效的病症，均可适用，治疗范围较广。临床常用于各种痛症，痹证，痿证，胃肠道疾病，癲狂，神经衰弱，脑血管意外后遗症，脊髓灰质炎后遗症，肌肉韧带、关节的损伤性疾病等，也可用于针刺麻醉。

四、注意事项

1. 在治疗前，检查电针器输出电流是否正常。治疗后应 输出调节电钮等全部退至“0”值，随后关闭电源。

2. 电针刺激量较大，需要防止晕针。调节电流时应逐渐从小到大，不能突然增强，防止引起肌肉强烈收缩，造成弯针、断 针。

3. 有心脏病者，在应用电针时应严加注意，避免电流回路经过心脏；在邻近延髓、脊髓等部位用电针时，电流的强度要小些，切不可作强电刺激，以免意外。孕妇慎用。

4. 毫针的针柄如经过温针火烧后，表面氧化不导电，不宜使用；若使用，输出线应夹持在针身上。

5. 如果电流输出时断时缓，可能是导线接触不良，所以检查修理后再使用。

〔临床应用〕

电针机的种类很多，因电源不同而分直流电针机和交流电针机；又可根据构造和性能不同而有低频震荡电针机、高频震荡电针机、感应断续脉冲电针机、蜂鸣式电针机、电子管电针机，半导体电针机等等，各有其不同特点。一般都是要求输出电压（峰值）在40~80伏之间，输出电流小于1毫安。

临床使用电针机时，首先检查电针机的输出电位器是否在“0”值，导线有无折断，一切正常，才能打开电源，选好波型和频率，进行应

用。在使用电针机时，如果出现两侧对称穴位的感觉不一样，一侧感觉过强，这时可以将左右输出电极对换。对换后，如果原感觉强的变弱，而弱的变强，则这种现象是由于电针机输出电流的性能所致。如果无变化，这说明是由于针刺在不同的解剖部位而引起。

使用电针器能代替医者长时间的持续运针，节省人力，又较客观的控制刺激量，便于掌握刺激强度。

复习思考题

1. 电针器的操作方法是什么？
2. 电针器的适应证是什么？
3. 使用电针器时应注意什么？
4. 电针器的波型有哪几种？各有什么治疗作用？临床上如何选择？

第六节水针

〔自学时数〕2学时

〔目的要求〕

1. 掌握水针的操作方法，适应范围和注意事项。
2. 熟悉埋线的操作方法，适应范围和注意事项。

水针又称穴位注射。是将药液注入穴位内，通过针刺和药液对穴位的刺激及药理作用，从而调整机体的功能，改善病理状态，是近代发展起来的针法。

一、用具及常用药物

1. 用具：根据使用药物的剂量大小及针刺部位的深浅选用不同的注射器及针头。常用的注射器为1毫升、2毫升、5毫升、10毫升、20毫升；常用针头5~6 (1/2)号普通注射针头，齿科用5号长针头，深部穴位可用9号长针头。

2. 常用药物：凡是可供肌肉的药物，都是供水针用。

常用的中药注射液有当归、红花、复方当归、板蓝根、徐长卿、灯盏花、补骨脂、柴胡、鱼腥草，复方当归、川芎、威灵仙等；西药有：25%硫酸镁，维生素B₁、B₁₂，维生素C、K，0.25~2%盐酸普鲁卡因，阿托品，利血平，麻黄素，抗生素，胎盘组织液，生理盐水，5~10%葡萄糖注射液等。

二、操作方法

1. 注射部位：是根据辨证施治，选取相应的腧穴，或压痛点或反应物（呈结带，条索状等）作为注射部位。
2. 注射方法：先选择适宜的消毒注射器和针头，抽好药液，把注射部位常规消毒，将针头按穴位所规定的方向和深度刺入穴位内，然后缓

慢推入或上下提插，使穴位“得气”后，如回抽无血，即可将药液注入。

一般疾病用中等速度推入药液；慢性病、体弱患者用轻刺激，将药液缓慢推入；急性病、体强者用强刺激，快速将药物推入。如注射药液量多时，可将注射针由深逐步提到浅层，边退针边推药，或将针更换几个方向注射药液，把药液推光。

3. 注射剂量：水针注射的药液剂量决定于注射部位及药物性质和浓度。一般成人，中药制剂、维生素类每个穴1次可注射1~2毫升；抗菌素类药物，每次可按原药剂量的1/5~1/2注射；5~10%葡萄糖液，每次可注射5~20毫升。注射部位，一般四肢、臀部肌肉较丰厚，注射量可多些；头、面、耳部皮肉较薄，注射量每穴不超过0.1~0.5毫升药液。

4. 注射疗程：每日或隔日注射1次，反应强烈者亦可隔2~3日1次，穴位可左右交替使用。10次为一疗程，每一疗程后，休息一周再继续下一疗程。

三、适应范围

凡是针灸的适应证，大部分都可以用水针治疗。多用于咳嗽、哮喘、痹证，痿证、腰腿痛、胃脘痛、神经痛、扭挫伤等。

四、注意事项

1. 水针注射时应注意药物的性能、药理作用、剂量、禁忌、副作用和过敏反应。凡是能引起过敏反应的药物（青霉素等），必须先作皮试。副作用强的药物应慎用。

2. 一般药液不宜注射到关节腔，脊髓腔和血管内。这些药液误入关节腔可引起关节红肿、发热、疼痛等反应；误入脊髓腔，有损害脊髓的可能。

3. 在主要神经干通过的穴位作水针注射时，应避开神经干，或浅刺以不达到神经干所在的深度为宜。若针尖触及神经干，患者有触电感，

要稍退针、然后注入药液，以免损伤神经组织。

4. 水针注射躯干部位的腧穴，不能过深，防止刺伤内脏。孕妇的下腹部、腰骶部及合谷、三阴交等穴，一般不宜作水针治疗，以防引起流产。

5. 严格遵守无菌操作，防止感染，最好一穴一换针头。

[附]埋线

埋线是将铬制羊肠线埋植在穴位内，利用羊肠线对穴位的持续性刺激作用，从而治疗疾病的一种方法。

1. 器材和穴位：

（1）器材：皮肤消毒用品、洞巾、0~1号的羊肠线、皮肤缝合针或12号的腰椎穿刺针（将针芯前端磨平）、持针器、剪刀、镊子、注射器、0.5~1%普鲁卡因、敷料等。

（2）穴位：多选用肌肉比较丰满部位的穴位，以背部及腹部穴位最常用。选穴原则与针刺方法相同，但取穴要精简，如哮喘取肺俞、膻中；胃病取胃俞、脾俞、中脘等。每次埋线1~8穴，可间隔2~4周治疗1次。

2. 操作方法：

（1）穿刺针埋线法：选准穴位，常规消毒局部皮肤，用0.5~1%普鲁卡因在穴上作皮肤内局麻，镊取按所需要的长度（1~2公分）一段的羊肠线，放置在腰椎穿刺针的针管内的前段，后接针芯。左手拇、食指绷紧或捏起进针部位皮肤，右手持针，刺入皮肤内，然后将针送至所需要的深度，出现针感后，边推针芯，边退针管，将羊肠线埋植在穴位的皮下组织或肌肉层，再将针孔涂以碘酒，敷盖上消毒纱布，用胶布固定。

（2）三角缝针埋线法：选定穴位后，用龙胆紫作进针标记，常规消毒局部皮肤，在穴位两侧1~1.5厘米处作皮内局麻。用持针器夹住带羊肠线的皮肤缝针，从局麻点刺入皮下组织与肌层之间或肌层内穿过穴位，

从对侧麻醉点穿出。捏起两针孔之间的皮肤，将两端线头紧贴皮肤剪断，放松皮肤，轻轻揉按局部，使羊肠线完全埋入皮下组织。用碘酒消毒针孔，敷盖上消毒纱布，用胶布固定。

(3) 切开埋线法：在选定的穴位上用0.5%盐酸普鲁卡因作浸润麻醉，用刀尖刺开皮肤（0.5~1.0厘米），先将血管钳探到穴位深处，经过浅筋膜达肌层探找敏感点按摩数秒钟，休息1~2分钟。然后用0.5~1.0厘米长的羊肠线4~5根埋于肌层内。羊肠线不能埋在脂肪层或过浅，以防止不易吸收或感染。切口处用丝线缝合，盖上消毒纱布，5~7天后拆去丝线。

3. 适应范围：用于多种疾病，如哮喘，咳嗽，鼻渊，胃脘痛，腹泻，遗尿，面瘫，癫痫，腰腿痛，痿证，脊髓灰质炎后遗症、神经官能症，半身不遂。

4. 注意事项

(1) 严格无菌操作，术后不要污染针孔，线头不得露出皮肤外，否则不能吸收，并容易感染。

(2) 操作宜轻巧，用力均匀，针透过皮肤时，不能用力过猛，避免折针。

(3) 神经干及大血管分布的表浅部位，避免埋线，以防损伤；胸背部埋线不宜过深，以防损伤内脏。

(4) 局部感染或溃疡者、发热期间、肺结核活动期、严重心脏病或孕妇均不宜作埋线疗法。

(5) 注意术后反应，有异常现象或发现感染化脓，应及时处理。

〔临床应用〕

水针的作用主要有以下几方面：

1. 针刺腧穴的作用：经络学说认为，经络是气血运行的通路，内联脏腑，外络肢节，使气血循行畅通无阻，充分发挥其营内卫外作用，从

而使脏腑组织间保持平衡，内外协调，保证人体健康。而腧穴是分布经络线上，位于体表呈点状，是脉气注输的部位，这就构成腧穴对人体有三种主要功能，即刺激点、传导点、反应点。腧穴与经脉和脏腑相通，针刺腧穴可调整经络与脏腑功能，而治疗疾病的。

2. 药物的刺激作用：穴位注射后，药物在穴位处滞留或存留时间较长，故可增强与延续穴位的治疗效能，并使之沿经络循行，以疏通经气，直达病所，发挥治疗作用。

3. 药物的治疗作用：各种药物都有其本身的治疗作用，注入机体后能发挥其调动人体的抗病能力。

埋线疗法操作简便易行。应用的羊肠线是一种异体蛋白，对人体有一定刺激作用。由于人体对羊肠线吸收慢，是一种慢性的良性刺激，从而达到治疗疾病的目的。施术后患肢局部温度会升高，可持续3~7天。少数病人可有全身反应，即埋线后4~24小时内体温上升，一般约在38℃左右，局部无感染现象，持线2~4天后体温恢复正常。

因个体差异，对有异常反应的患者，如对羊肠线过敏，治疗后出现局部红肿、瘙痒、发热等反应，甚至切口处脂肪液化，羊肠线溢出，应适当作抗过敏处理。

复习思考题

1. 水针怎样操作？
2. 水针的适应范围是什么？
3. 水针治疗时注意事项是什么？
4. 埋线疗法有哪几种方法？怎样操作？
5. 埋线疗法适用哪些病证？
6. 埋线疗法的注意事项是什么？

第七节 耳针

〔自学时数〕2学时

〔面授时数〕1学时

〔目的要求〕

1. 掌握耳针的操作方法，适应范围和注意事项。
2. 掌握耳穴的分布规律及常用耳穴。

耳针是在耳廓穴位用针刺等刺激防治疾病的一种方法。它具有操作简便、适应证广、副作用少等特点。并可用于外科手术麻醉，对诊断疾病也有一定的参考意义。

我国用耳穴诊治疾病，已有悠久的历史。《黄帝内经》中有关耳穴记载达三十余处。《灵枢·厥病》说：“厥头痛，头痛甚，耳前后脉涌有热，泻出其血，后取足少阳。”《灵枢·口问》又说：“耳为宗脉之所聚。”《灵枢·邪气脏腑病形》又说：“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于头面而走空窍。……其别气走于耳而为听，”这都说明耳与全身经脉有密切关系。汉·张仲景说：“救卒中而目闭者，捣韭汁灌之于耳”。指出耳有开窍醒神的作用。唐·孙思邈在《千金方》中说：“耳中孔上横梁（是指耳轮脚），针灸之，治马黄黄疸，寒暑疫毒，”说明耳穴可以治疗传染病。明·杨继洲在《针灸大成》中说：“艾灸耳尖，治目生翳，”说明耳穴能治眼病。到目前为止，应用耳针可以治疗疾病已达150多种。

一、耳廓表面解剖

耳廓主要是由弹性纤维软骨、软骨膜、韧带及覆盖在最外层的皮下组织和皮肤所构成。在皮下有丰富的神经、血管和淋巴分布。耳廓分前面和背后，耳廓前面为凹面，耳廓后面为凸面。其耳廓表面解剖如下：

1. 耳轮：耳廓最外圈的卷曲部分。
2. 耳轮脚：耳轮深入到耳腔内的横行突起部分。
3. 耳轮结节：耳轮后上方稍突起处。
4. 耳轮尾：耳轮末端与耳垂的交界处。
5. 对耳轮：在耳轮的内侧，与耳轮相对的隆起部，其上方有两分叉，向上分叉的一支称对耳轮上脚，向下分叉的一支称对耳轮下脚。
6. 三角窝：对耳轮上脚、下脚之间的三角形凹窝。
7. 耳舟：耳轮与对耳轮之间的凹沟，又称舟状窝。
8. 耳屏：耳廓前面的瓣状突起，又称为耳珠。
9. 屏上切迹：耳屏上缘与耳轮脚之间的凹陷。
10. 对耳屏：对耳轮下方与耳屏相对的隆起部。
11. 屏间切迹：耳屏与对耳屏之间的凹陷。
12. 屏轮切迹：对耳屏与对耳轮之间的稍凹陷处。
13. 耳垂：耳廓下部无软骨之皮垂。
14. 耳甲艇：耳轮脚以上的耳腔部分，又称耳甲窝。
15. 耳甲腔：耳轮脚以下的耳腔部分。
16. 外耳道开口：在耳甲腔内，为耳屏所遮盖着的孔窍（图246）。

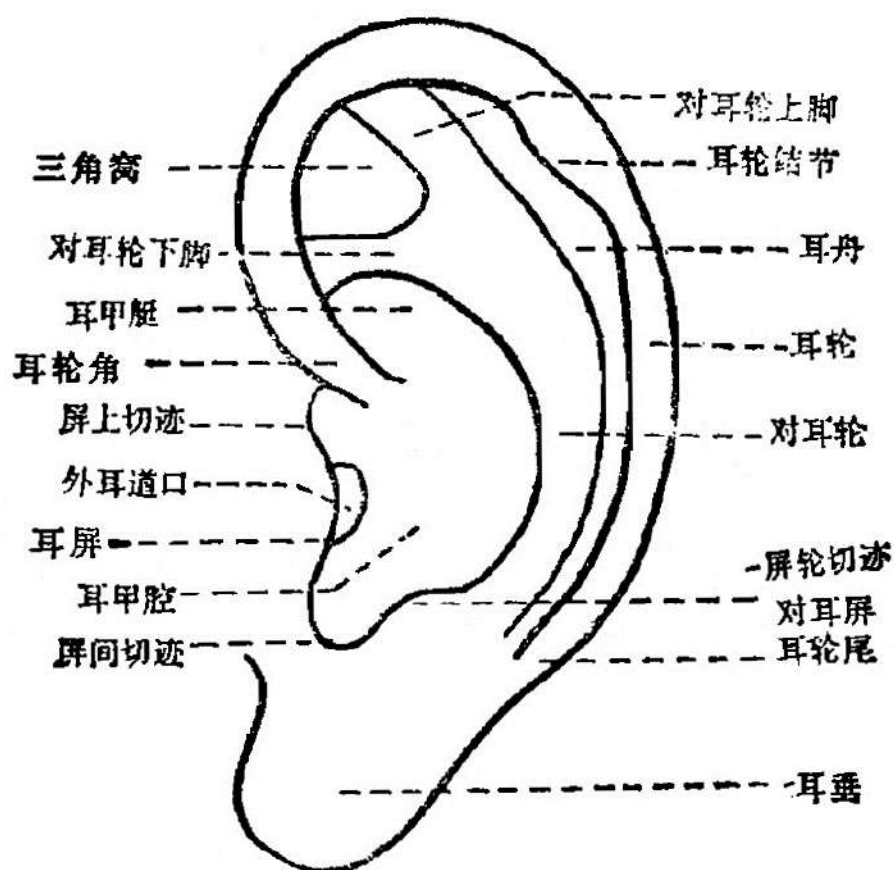


图 246 耳廓体表解剖

二、耳与经络脏腑的关系

祖国医学认为，人体虽然分脏腑、九窍、百骸等，但它们都是有机整体的部分，同时每一个局部又是一个小整体。耳并不单纯是一个孤立的听觉器官，它和经络、脏腑有着密切关系。《阴阳十一脉灸经》中，提到了与上肢、眼、颊、咽喉相连系的“耳脉”。《灵枢·经脉》中有六条阳经的经脉循行分别到耳中和耳的周围，到耳中的有手太阳、阳明经和手足少阳经四条经脉；到耳周围的有足阳明和足太阳经。六阴经的经脉循行虽然不直接入耳，但其经别的循行到达颈项附近后，再合入阳经而上行，因此也和耳有一定的联系。所以《灵枢·邪气脏腑病形》说：“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面而走空窍。其精阳气上走于目而为睛。其别气走于耳而为听”。另外《灵枢·经筋》和《奇经八脉考》中也指出耳与经筋、奇经八脉都有一定的关系。耳不但和经络有关系，并且通过经络与脏腑也有着密切的关系。《素问·金匱真言论》说：“南方赤色，入通于心，开窍于耳，藏精于心”。《灵枢·脉度》说：“肾气通于耳，肾和则耳能闻五音矣”。《难经·四十难》说：“肺主声，令耳闻声。”《证治准绳》有：“肺气虚则少气，……是以耳聋”的记载，可见耳与脏腑在生理、病理方面也是息息相关的。

三、耳穴的分布

当人体的脏腑或躯体有病时，往往会在耳部的一定部位出现某些病理反应，如压痛、导电性能改变、变形、变色、结节、脱屑等。针刺这些部位时可以防治疾病，这些部位就是耳穴。

耳穴在耳廓的分布有一定的规律，与身体各部相应的穴位在耳廓的分布象一个倒置的胎儿。一般来说，与头面相应的穴位在耳垂；与上肢相应的穴位在耳舟；与躯干和下肢相应的穴位在对耳轮及对耳轮上、下脚；与内脏相应的穴位多集中在耳甲艇和耳甲腔，其分布如图247。

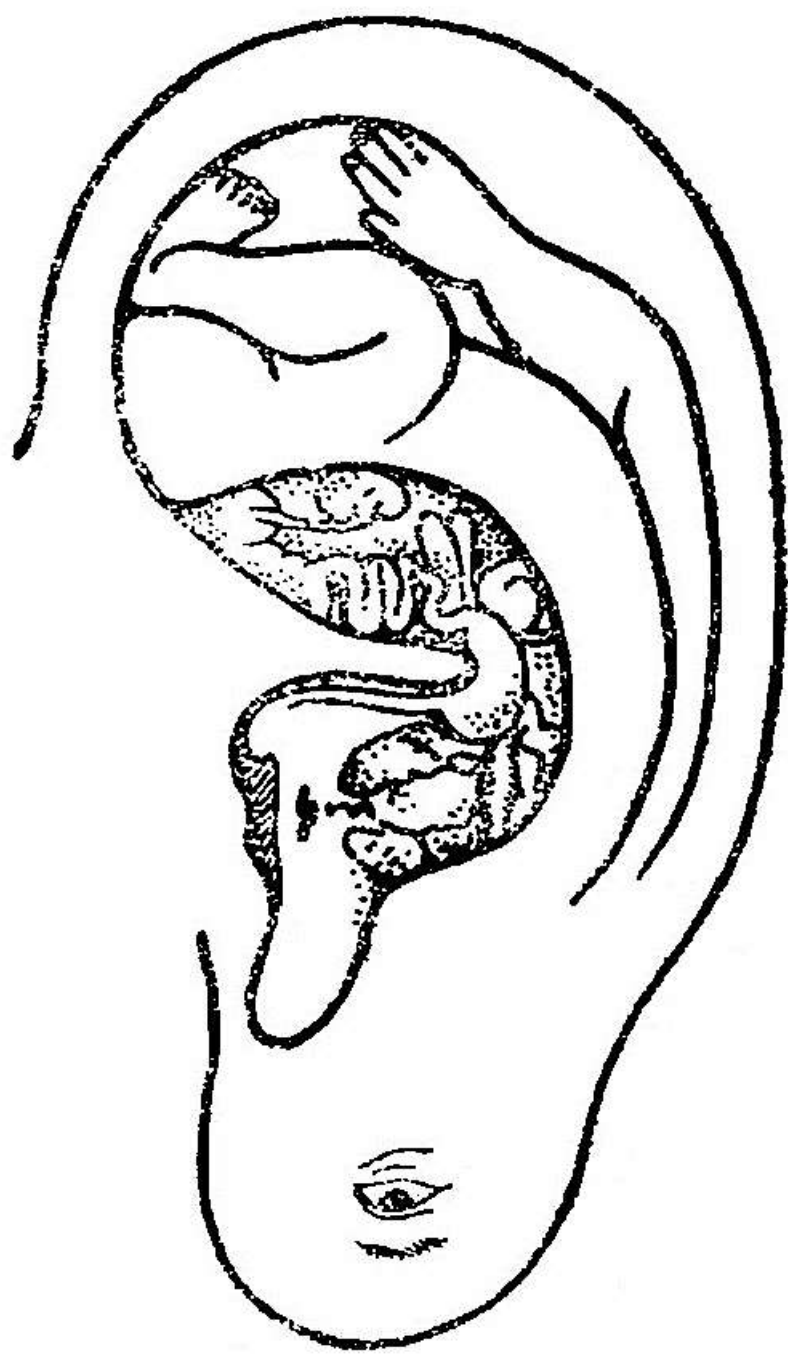


图 247 耳穴形象分布示意图

四、常用耳穴的定位和主治

耳穴来源于实践。据不完全统计，在耳廓已发现200多个耳穴，现将临床常用耳穴在耳廓上的定位（图248）和主治介绍如表13。

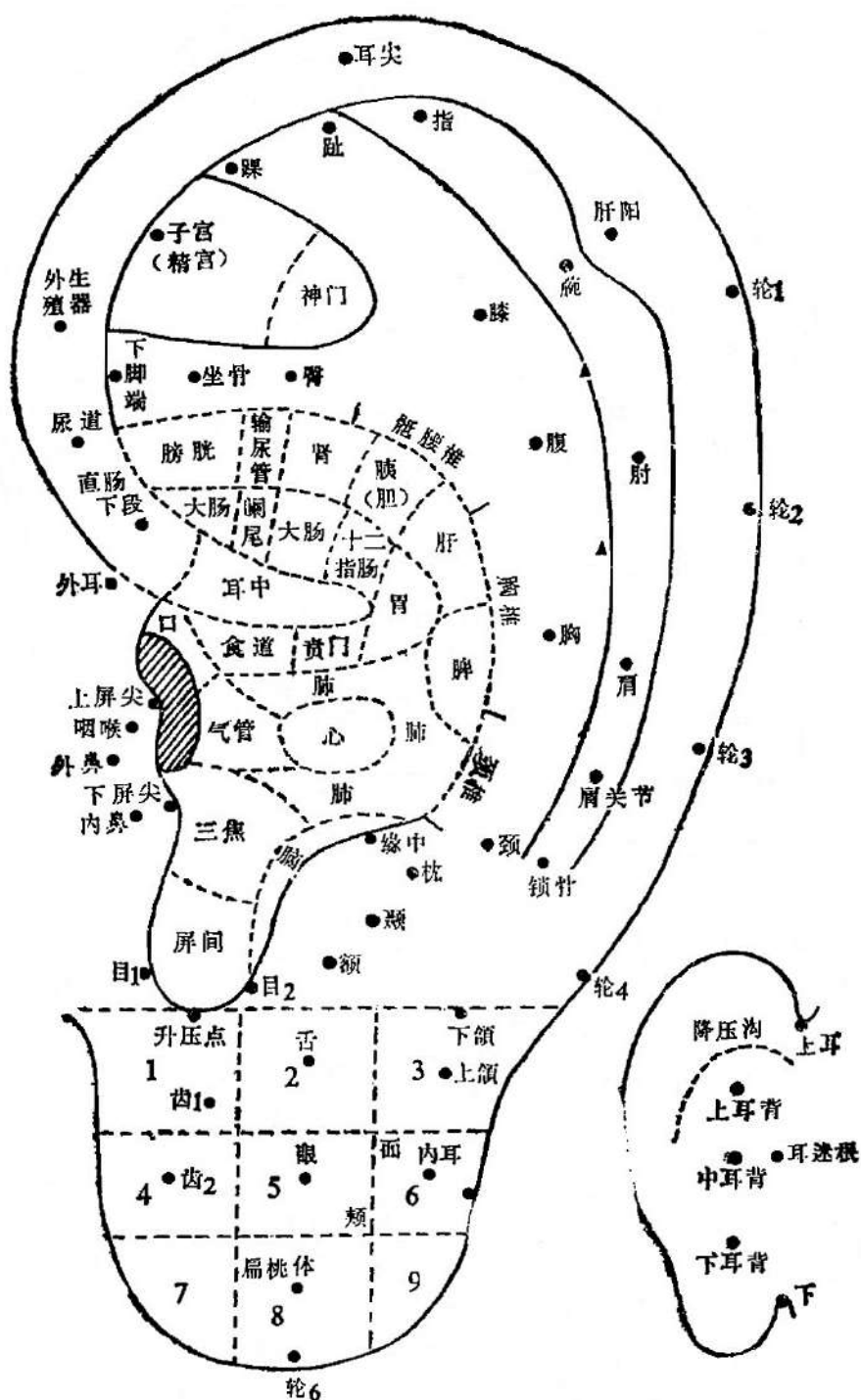


图 248 常用耳穴分布示意图

图 13 常用耳穴定位和主治表

[illegible]

五、耳针的应用

（一）选穴处方原则

1. 辨证选穴：根据中医的脏腑、经络学说，辨证选耳穴。如皮肤病，按肺主皮毛的理论，选用肺；眼病，根据肝开窍于目，或肝主目或肾主水的理论，选用肝穴和肾穴等。
2. 对症选穴：根据现代医学的生理、病理知识，对症选穴。如月经不调选取内分泌（屏间）；胃痛选取交感（下脚端）；输液反应选取肾上腺（下屏尖）等。
3. 按病选穴：根据病变部位，在耳廓上取相应部位选穴。如胃病选取胃穴；眼病取目1、目2；腹泻选大肠、小肠；肩痛选肩等。
4. 经验选穴：根据临床经验选取有效穴。目赤肿痛取耳尖，高血压取降压沟等。

以上可以单独使用，亦可两种或两种以上方法配合使用，力求少而精，一般每次应用2~3穴左右。多用同侧，亦可取对侧或双侧。

5. 常见病症选穴处方举例：（1）感冒：肺、内鼻、下屏尖。

（2）中暑：心、枕、脑。

（3）咳嗽：支气管、肺、神门。

（4）哮喘：平喘、肺、下脚端、下屏尖。

（5）眩晕：肾、神门、内耳。

（6）胃痛：胃、神门、脑、下脚端。

（7）月经不调：子宫、卵巢、屏尖。

（8）痛经：子宫、肾、屏间、下脚端。

（9）急惊风：心、神门、缘中、下脚端。

（10）遗尿：肾、膀胱、缘中、脑。

- (11) 扭伤：相应部位、神门、脑。
- (12) 输液反应：平喘、下屏尖。
- (13) 便秘：大肠、直肠下段、下脚端。
- (14) 腹泻：大肠、小肠、下脚端、脾。
- (15) 目赤肿痛：眼、肝、耳尖。
- (16) 中耳炎：肾、内耳、屏间、枕。
- (17) 引产、催产：子宫、膀胱、屏间、脑、腰椎。
- (18) 产后宫缩痛：子宫、神门、脑、屏间。
- (19) 电光性眼炎：肾、肝、眼、神门。
- (20) 晕车、晕船：脑、缘中、枕、胃。
- (21) 蛇丹：相应部位、肺、肝、下屏尖、屏间。

（二）操作方法

1. 寻找反应点：根据病情需要确定处方后，除按耳穴的位置选穴外，还应结合寻找反应点进行针刺，有助于提高疗效。寻找方法有三种：
①肉眼观察法：直接观察耳廓的形态，色泽等方面的病理性改变。如硬结、丘疹、凹陷、水泡、鳞片、色素沉着等。这些反应点可作为探查耳穴的参考。
②压痛点探查法：用探棒或火柴棒头以均匀的压力，在与疾病相应的耳区周围逐渐向中间顺序探查。当压及反应点时，患者会有呼痛，或皱眉、躲闪等反应。但在探压时用力要均匀，时间要相等，并应事先告诉患者仔细体会各点的压痛程度，找出压痛最明显的反应点。
③电测定法：当有疾病时，多数患者相应耳穴的电阻下降。这些电阻下降的穴位，皮肤导电量必然增高，故又称良导点。这种良导点，就可作为耳针治疗的刺激点。探测时，患者一手握电极，医者手执探测头，在患者的耳廓上进行探查，当电棒触及敏感点（良导点）时、如电阻低的耳穴，可以通过指示信号，音响或仪表等反映出来。这种电测定法和压痛法比较，具有操作简便、准确性较高等优点。
 2. 消毒：使用耳针必须严格消毒。耳穴皮肤先用2%碘酒消毒，再用75%酒精脱碘。如果消毒不严格，感染后容易引起耳软骨膜炎。
 3. 针刺：根据需要选用0.5寸短柄毫针或用特定之图钉型揸针，亦可用水针和电针。毫针进针时以左手固定耳廓，右手进针。进针深度以穿破软骨但不透过对侧皮肤为度。穴位注射不透过软骨，药液注射在软骨与皮肤之间。揸针、电针、水针的具体操作方法见本章第三、五、六节。其它还有用铁砂、磁石、菜籽等作压迫刺激的。
- 针刺后、多数患者局部有疼痛或热胀感，少数有痠、重感，甚至有特殊的凉、麻、热等感觉沿着经络路线放射传导。一般有这些感觉的疗效较好。
4. 留针：毫针一般留针20~30分钟，慢性病、疼痛性病可留针1~2小时或更长。留针期间可间歇捻针，以加强刺激。也可应用耳针埋针法。

5. 出针：出针后用消毒干棉球压迫针孔，防止出血。必要时再涂以75%酒精或2%碘酒以防感染。

6. 疗程：一般每天1次或隔日1次，连续10次为一疗程，然后休息5~7天，再开始下一疗程。

六、注意事项

1. 对初诊患者，在针刺前必须说明耳针疗法的特点，针刺耳穴后的反应，使患者有充分的思想准备，才能配合治疗。
2. 严密消毒，预防感染。耳廓冻伤和有炎症的部位禁针。若见针孔发红，患者觉耳廓胀痛，可能有轻度感染，应及早用2%碘酒涂擦或者口服消炎药物。
3. 有习惯性流产史的孕妇应禁针。对年老体弱的高血压、动脉硬化患者，针刺前后应适当休息，针刺手法要轻，留针时间要短，以防意外。
4. 耳针亦可发生晕针，须注意预防，如发生晕针要及时处理。
5. 对扭伤及肢体活动障碍的患者，进针后待耳廓充血发热，宜嘱患者适当活动患部，或在患部按摩、加灸等，可增强疗效。

〔临床应用〕

耳针疗法操作简便，适应症广，疗效迅速，选穴是治疗的关键。选穴不能只限于耳穴分布图或模型上所标出的位置生搬硬套，必须结合直观检查法、压痛检查法或电测定法等选定反应点。特别压痛检查法，是目前临床常用的探寻方法。少数人耳廓上一时测不到压痛点，可用手按压一下该区而后再测，或在对侧耳廓的反应区探找，如仍无痛点反应，可休息片刻再测，如再探查不到可按对症选穴处理。亦可应用耳穴探测仪进行探测。

耳针除了用针刺外，还可用压丸法（铁砂、王不留行籽、磁珠等），在耳廓的反应点上，把铁砂等用胶布固定，可随时压迫，使之产生刺激而达到治疗作用。

复习思考题

1. 什么叫耳针？它的主要适应症有哪些？
2. 耳廓表面的各部名称是什么？
3. 什么叫耳穴？耳穴的分布规律是什么？
4. 耳穴的处方原则是什么？
5. 怎样测定耳穴？
6. 耳针应该怎样操作？
7. 耳针的注意事项是什么？
8. 试述神门、脑、下脚端、下屏尖、屏间、胃、耳中的位置及主治。

第八节头针

〔自学时数〕2学时

〔目的要求〕

掌握头针的操作方法及注意事项。

根据祖国医学“头为诸阳之会”，“诸经皆归于脑”，以及手、足三阳经都会于巅顶的理论，针刺头部腧穴可起通经活络、调节经气的作用。头针是针刺与现代医学大脑皮层的功能定位理论相结合的一种疗法。

一、刺激区的定位和主治作用

为了便于刺激区的定位，在头部设有两条标准定位线。

前后正中线：是从两眉间中点至枕外粗隆尖端下缘经过头顶正中的连线（图249）。

眉枕线：是从眉中点上缘和枕外粗隆尖端的头侧面连线（图249）。

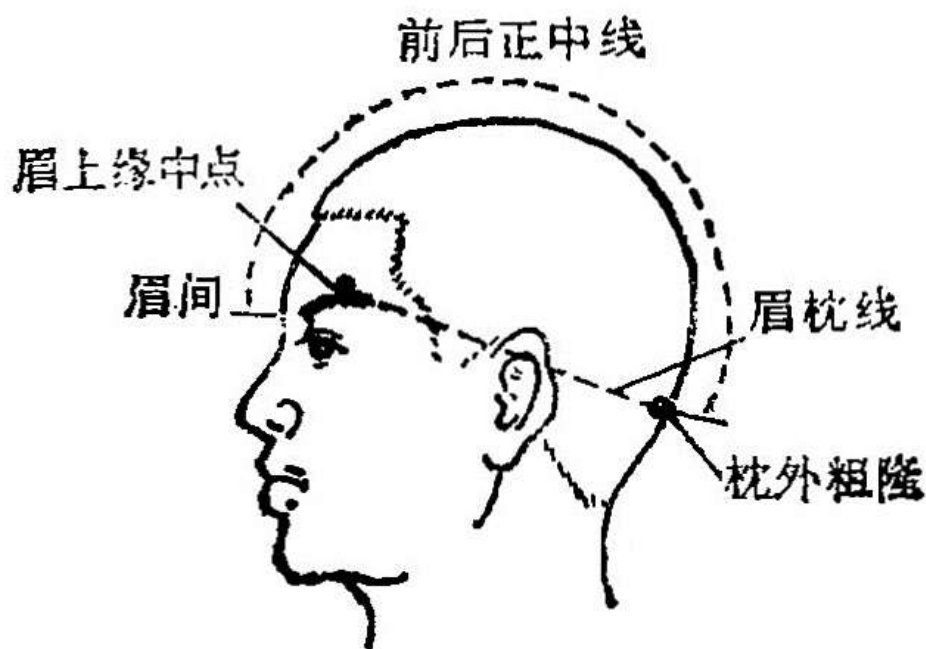


图 249 (标定线定位)

(一) 运动区 (图250)

定位：上点在前后正中线中点往后0.5厘米处，下点在眉枕线和鬓角发际前缘相交处。如果鬓角不明显，可以从颧弓中点向上引垂直线，此线与眉枕线交叉处向前移0.5厘米为运动区下点。上下两点连线即为运动区。运动区又可分为上、中、下三部。

1. 上部：是运动区的上1/5，为下肢、躯干运动区。

2. 中部：是运动区的中2/5，为上肢运动区。

下部：是运动区的下2/5，为面运动区（语言一区）。

主治：

1. 上部：对侧下肢、躯干部瘫痪。

2. 中部：对侧上肢瘫痪。

3. 下部：对侧中枢性面神经瘫痪，运动性失语（部分或完全丧失语言能力，但基本保持理解语言的能力），流涎，发音障碍。

（二）感觉区（图250）

定位：在运动区向后移1.5厘米的平行线，即是感觉区。感觉区可分为上、中、下三部。

1. 上部：是感觉区的上1/5，为下肢、头、躯干感觉区。
2. 中部：是感觉区的中2/5，为上肢感觉区。
3. 下部：是感觉区的下2/5，为面部感觉区。

主治：

1. 上部：对侧腰腿痛、麻木、感觉异常，后头、颈项部疼痛，头晕，耳鸣。
2. 中部：对侧上肢疼痛、麻木、感觉异常等。
3. 下部：对侧面部麻木、偏头痛、颞合关节炎等。

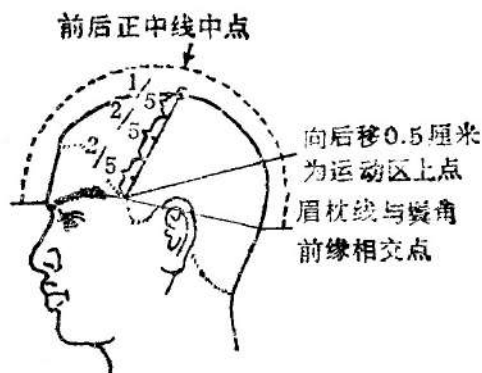


图 250 头针运动区定位



图 251 头针侧面刺激区定位

（三）舞蹈震颤控制区（图251）

定位：在运动区向前移，1.5厘米的平行线。

主治：舞蹈病，震颤麻痹，震颤麻痹综合征。

（四）晕听区（图251）

定位：从耳尖直上1.5厘米处、向前及向后各引2厘米的水平线。

主治：眩晕，耳鸣，听力下降。

（五）言语二区（图251）

定位：从顶骨结节后下方2厘米处引一平行于前后正中线的直线，向下取3厘米长直线。

主治：命名性失语（又称健忘性失语，病人称呼“名称”能力障碍，如病人不会叫“椅”，只说是“坐的”；其他人叫椅时，他能听懂）。

（六）言语三区（图251）

定位：晕听区中点向后引4厘米长的水平线。

主治：磁觉性失语（病人理解言语能力障碍，常答非所问）。

（七）运用区（图251）

定位：从顶骨结节起分别引一垂线和与该线夹角为40度的前后两线，长度均为3厘米。

主治：失用症（又称运动不能症，患者肌力、肌张力及基本运动正常，但存在技巧能力障碍）。

（八）足运感区（图252）

定位：在前后正中线的中点旁开左右各1厘米，向后引3厘米长，平行于正中线。

主治：对侧下肢瘫痪、疼痛、麻木，急性腰扭伤，夜尿，皮层性多尿；子宫下垂等。

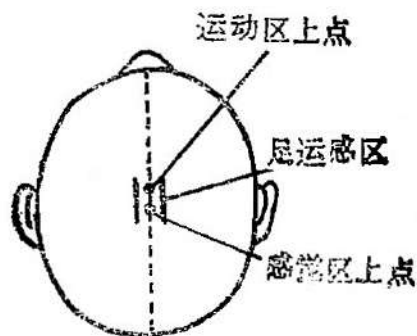


图252 头针顶面刺激区定位

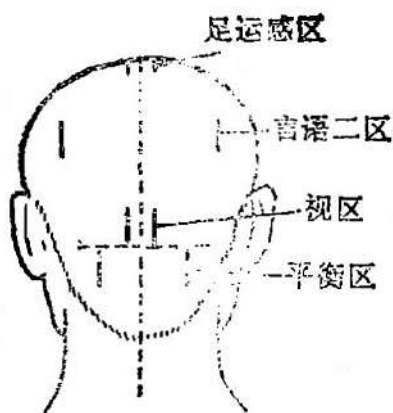


图253 头针后面刺激区定位

(九) 视区 (图253)

定位：在前后正中线的后点旁开1厘米处的枕外粗隆水平线上，向上引平行于前后正中线的4厘米长的直线。

主治：皮层性视力障碍。

(十) 平衡区 (图253)

定位：在前后正中线的后点旁开3.5厘米处的枕外粗隆水平线上，向下引平行于前后正中线的4厘米长直线。

主治：小脑疾病引起的共济失调，平衡障碍，头晕，脑干功能障碍引起的肢体麻木瘫痪等。

(十一) 胃区 (图254)

定位：从瞳孔直上发际处为起点，向上引平行于前后正中线2厘米长直线。

主治：胃炎、胃溃疡等引起的胃痛，上腹部不适等。

(十二) 胸腔区 (图254) 定位：在胃区与前后正中线之间，发际上下各引2厘米长直线。

主治：支气管哮喘，胸部不适，胸痛，胸闷，心悸，冠状动脉供血不足等。

（十三）生殖区（图254）

定位：从额角处向上引平行于前后正中线的2厘米长直线。

主治：功能性子宫出血，盆腔炎，子宫脱垂，白带多等。

选穴方法：单侧肢体疾病，选用对侧刺激区；两侧肢体疾病，选用双侧刺激区；内脏全身疾病或不易区别左右的疾病，可双侧取穴。一般根据疾病选用相应的刺激区，并可选用有关刺激区配合治疗。

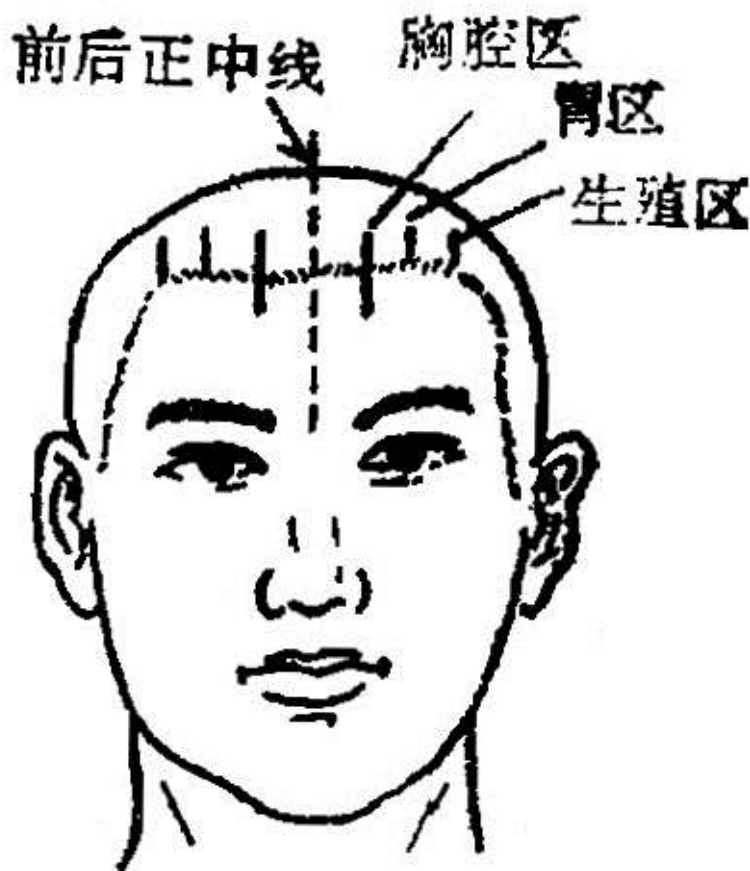


图 254 头针前面刺激区定位

二、操作方法

1. 体位：明确诊断，选定刺激区让患者采取坐位或卧位，以医者操作方便，有利于捻针为准。分开头发，常规消毒。
2. 针具：选择26~28号、长1.5~2.5寸长的不锈钢毫针。
3. 进针：针与头皮呈30度左右夹角，用夹持进针法将针刺入帽状腱膜下，或者是刺入皮下或肌层，达到该区的长度，然后、运针。
4. 运针：头针的运针只捻转不提插。医者肩、肘、腕关节、拇指固定，食指半屈曲状，用拇指第一节的掌侧面与食指第一节的桡侧面捏住针柄，然后以食指指掌关节不断曲伸，使针体回来快速旋转200次/分左右，每次左右旋转各两转左右。捻转持续约0.5~1分钟，然后留针5~10分钟，捻转两次，即可出针。捻转时或留针时，家属协助患者（或患者自己）活动肢体，加强患肢功能锻炼，有助于提高疗效。一般3~5分钟刺激后，部分患者在病变部位（患肢或内脏，个别患者在健侧）会出现热、麻、胀、凉、抽动等感应，这样疗效较好。也可用电针代替手捻进行治疗（图255）。

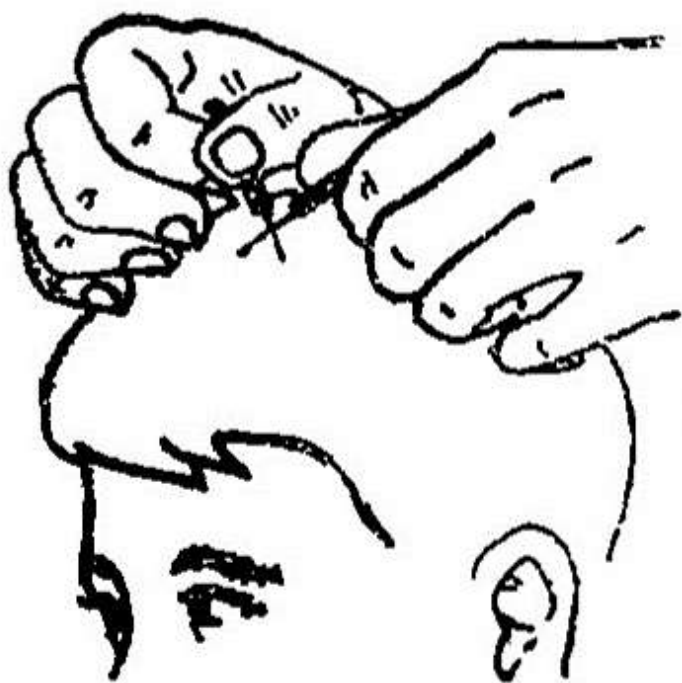


图 255 头针运
针示意图

5. 出针：出针时要用消毒干棉球压迫针孔，以防出血。如有出血或皮下血肿，应轻度压迫按摩，血肿可自行吸收，无需特殊处理。

6. 疗程：每日或隔日1次，一般10~15次为一疗程。体息 5~7天，再作下一疗程的治疗。

三、适应范围

头针主要适用于脑源性疾患，如瘫痪、麻木、失语、眩晕、耳鸣、舞蹈病等。此外，也可治疗腰腿痛、夜尿、三叉神经痛，肩周炎、各种神经痛等。头针在治疗的基础上又创造了头针麻醉。已经应用于外科的多种手术。

四、注意事项

1. 对脑溢血患者，要待病情及血压稳定方可进行头针治疗。
2. 凡患者并发有高热、心力衰竭等，不宜立即采用头针治疗。
3. 头部长有头发，因此必须做到严密消毒，以防感染。
4. 由于头针刺激较强，刺激时间较长，医者要注意观察患者表情，以防晕针。
5. 头皮血管丰富，容易出血，起针时要用消毒干棉球压迫针孔，以防出血。

〔临床应用〕

头针重点要掌握各刺激区的位置、主治和操作方法。采用头针治病时，在治疗前必须有明确的定位诊断，为选刺激区提供依据，否则就不能收到良好的效果。而刺激区要按规定的方法选取，这就应注意前发际、鬓角是否清楚，如果有脱发，鬓角和前发际不清，取刺激区就有困难。如鬓角不清，运动区的下点就无法确定，这时就要找解剖标志，可从颧骨弓中点向上引垂线，此线与眉枕线的交叉点向前移0.5厘米处就是运动区的下点；如果前发际不清，取胸腔区、胃区、生殖区就有困难，所以前发际不清者就可以在两眉之间的中点向上量5厘米处为一点，引垂直前后正中线的一条直线，即为前发际。在刺激区的主治中提到的运动性失语，是指患者部分或完全丧失言语能力，但基本保留着理解言语的能力；命名性失语是指病人称呼“名称”能力障碍，如病人不会叫“铅笔”，而只能说是“写字用的”，别人说铅笔时他也懂得；感觉性失语，是指患者理解语真能力障碍，往往答非所问。失用症又称“运用不能症”，患者肌力、肌张力及基本运动正常，但存在技巧能力障碍，如患者不能解扣、不能写字等。

头针操作，捻针是很重要的一环。在捻针时要求固定、快速，持续捻转。

头针刺激这有的比较长，一根针很难贯通。可将刺激分成几份，每份针刺一针。如运动区就分成三份，运动区上1/5针刺一针，中2/5针刺一针，下2/5针刺一针。

复习思考题？

1. 什么叫头针疗法？它的主要适应证是什么？
2. 试述头针的操作方法。
3. 运动区、感觉区、足运感区、平衡区、晕听区的定位和主治？

第四章 针刺麻醉

- 第四章 针刺麻醉

第一节 针麻概念和简史

[自学时数] 1学时

[目的要求]

1. 了解针麻的概念。
2. 了解针麻的发展简史。

针刺麻醉（简称针麻）是选择适当穴位针刺，在患者清醒状态下施行外科手术的一种麻醉方法。它是我国中西医根据针刺有镇痛和调整人体生理功能的作用启发下创造出来的。是中西医紧密团结，运用现代科学的知识和方法，继承发展祖国医学所取得的一项新成就。也是针灸学的一项新发展。针刺与外科手术相结合，提高了外科手术的操作和效果。针麻能充分发挥病人的主观能动性作用，又为不能接受药物麻醉的患者开辟了一条新的道路。针麻还对理论研究提出了新的课题，推动了经络、经穴——脏腑相关，痛觉生理学，镇痛原理的研究工作。

针刺麻醉是在中医针灸疗法的临床实践基础上发展起来的。我国的针灸疗法已有几千年的悠久历史，是中国医药学伟大宝库的重要组成部分。针灸疗法中有一条很重要的经验，就是针刺能够止痛。《灵枢经》的《邪气藏府形》、《经脉》、《经筋》、《周痹》等篇中就有关于针刺治疗头痛、牙痛、腰痛、关节痛以及各种腹痛等记载。1958年以来，针灸疗法在全国范围内得到了空前广泛的普及，并且有了许多新的发展。在广泛应用针刺止痛的基础上，许多地方的医务人员先后进行了用针刺穴位来代替药物麻醉的尝试。1959年春，在西安召开了全国针刺麻醉工作的现场会议，各地医务人员在会上交流了用针刺穴位代替药物麻醉的经验和体会；七月于上海召开的全国中医经络针灸学术座谈会和1960年七月于上海召开的全国中西医结合研究工作经验交流会议上，就有陕西、山西、甘肃、黑龙江、河北、山东、江苏、安徽、福建、江西、湖南、广东、广西、云南、四川、北京、上海等地提出了关于针刺经络穴位麻醉的报告；江西、浙江等地提出了

关于耳针麻醉的报告；江苏、上海等地提出了小剂量药液穴位注射麻醉的报告。此外，陕西、河北、湖南、广东，甘肃、北京、上海等地还提出了有关针刺镇痛的理论原理研究的报告。

在1966年春，在上海召开的全国针刺麻醉工作座谈会上，对穴位配方、刺激方法、外科操作和术中护理等进行了交流，并取得了初步经验，为针麻在以后的发展打下了基础。1970年五月，卫生部委托上海举办了全国针刺麻醉学习班，进一步推动了针麻的普及工作。其次，随着针麻的推广普及，针麻的临床效果不断得到提高，操作方法也不断减化了。例如北京、上海等地的医务人员在实践中将肺切除、胃切除等针麻手术都从最初取几十个穴位减少到很少几个甚至一、二个穴位。江苏省的医务人员也在实践中不断总结经验，使耳针麻醉的临床应用不断扩大，效果得到了显著提高；上海、江苏、黑龙江、山西、贵州、陕西等地的医务人员还创造了许多新的麻醉方法，如面针麻醉、鼻针麻醉、“赤医针”麻醉、手针麻醉、足针麻醉以及耳根麻醉、头针麻醉等各种针麻方法。在1971年七月《人民日报》公布了针麻研究成果以后，进一步推动了针麻原理的研究工作。目前我国医务工作者和科学工作者，根据“百花齐放、百家争鸣”的方针，正在对针麻的临床规律和基本原理进行深入的研究，为麻醉方法又开辟一条新的道路。

[临床应用]

针刺麻醉是一种新的麻醉途径，因此对针刺麻醉概念要有所了解。从针麻简史中就可以了解到，针麻是逐渐改进和完善的，为外科手术麻醉开辟了一条新路，突破了外科手术必须使用麻醉药物的传统，具有临床实用价值，对医学发展作出了重大贡献。

复习思考题

- 1、什么是针刺麻醉？
- 2、针刺麻醉是在什么基础上研究成功的？
- 3、针刺麻醉是在何时向世界人民公布成功的？

第二节 针麻特点和方法

[自学时数] 1学时

[目的要求]

1. 了解针刺麻醉的特点。
2. 掌握针刺麻醉的操作方法。

一、针麻特点

1. 适应范围广：针麻目前已应用于普通外科、神经外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、胸外科、骨科、妇产科、泌尿外科、小儿科等多种手术病种，具有比较广泛的适应证。我国应用针麻进行手术，已达二百余万例，应用范围已经推广到100多种大小手术，成功率达80%左右，通过大量临床实践，约有20~30种常用针麻手术效果稳定。一般认为多在头、颈、胸部手术效果好。如甲状腺、上颌窦、青光眼、输卵管结扎等已普及应用；剖腹产、脾切除、胃大部切除、全喉截除等也取得较好成效。有些单位已把颅脑手术、前列腺切除、半月板摘除、肺叶切除等针刺麻醉列为首选方法。

近年来，用针麻进行体外循环、心内直视手术也取得了满意的效果。由于针麻方法具有使用安全、生理扰动少优点，因而对药物过敏、肝肾功能较差，以及休克、病危、衰弱等全身状态差的病例均可应用。

2. 生理干扰少：由于针刺经穴具有调整人体各种功能的作用，因此针麻手术时，患者的血压、脉搏、呼吸都比较平稳，手术后不会有后遗症，伤口痛也较轻，术后康复较快。

3. 针麻使用安全：针麻无药物麻醉因用药过量或患者因麻醉药过敏而发生麻醉意外。对心、肺、肝、肾等功能不良或年老体弱、休克等不宜采用药物麻醉的患者，应用针刺麻醉都比较安全。

4. 术后痛苦少：针麻手术时患者保持清醒状态、患者痛觉变迟钝外，其他各种感觉和运动功能仍很正常。因此，患者可与医生合作，有利手术进行。例如：做三叉神经感觉支切断术时，可以及时测定患者感觉缺失区的范围，避免将神经根切断过多或过少；甲状腺手术时，通过和患者交谈听其发音，可防止误伤喉返神经。另外在针麻下手术，术后很少有药物麻醉所出现的头痛、鼓肠、尿闭等副作用，并有进食早、活动早、身体康复快等优点。

针麻虽然具有安全、有效、生理扰乱少、术后恢复快、简便易行等优点。但针刺麻醉对某些部位手术或某些病例还有镇痛不全、内脏牵拉

时有不舒适反应，有时腹肌不够松弛等情况，可辅助适量的安定镇痛药物以及在手术的关键部位施以少量麻醉药，以增强麻醉效果。

二、针麻方法

1. 术前准备：在手术之前，参加手术的医务人员就患者的病情、病史、思想情况一起进行分析讨论，达到统一认识，确定针麻手术方案。充分估计术中可能出现的各种情况，准备采取相应的措施。由于针麻手术时患者处于清醒状态，因此，在术前须将针麻的意义、特点、方法、过程和效果向患者介绍；同时把手术过程中可能有不适感觉等讲清楚，使其有思想准备。为了解患者针感情况和对针刺耐受情况，必须术前试针1~3次和患者在术中配合手术的训练（如开胸时做深呼吸等）。这样就便于在手术时采用适当的刺激方法和给予适当的刺激量。

2. 选穴原则：针麻选穴原则与针刺治疗选穴原则相同。要选穴少，针感好，才能达到镇痛的目的。

（1）体针选穴：体针麻醉选穴是以十四经穴为主的一种麻醉方法。具体选法有四种：

循经选穴：是根据“经脉所过，主治所及”的理论，在与手术切口部位或有关内脏相关的经络上，选取针感较强、镇痛及调整效果较好的腧穴。如头、面、颈、项部手术，选用手阳明大肠经的合谷穴，胃大部切除术，先用足阳明胃经的合穴足三里等。

在选穴时，还要注意穴位的特殊性能和主治作用。如因“合治六府”，开腹当选用“下六合穴”；“输主体重节痛”，四肢手术当选用“五输穴”的“输穴”。

邻近选穴：在循经取穴的同时，为加强局部的镇痛效果，还可根据“以痛为腧”的理论，选取手术部位附近的穴位。如拔上牙选颊车、颧髎；剖腹产选取带脉穴等。做内脏手术还可根据五脏六腑各有“募”、“俞”穴以及相应夹脊穴，以加强镇痛的效果。

辨证取穴：根据所表现的症状及与脏腑、经络的关系，选取经验有效的穴位，以加强镇痛效果。如胸闷、心悸选内关，可达镇静之效；胸

腔手术，可选用心包经的郄门穴，可达到宁心安神的作用；眼部手术，可选用足少阳胆经的络穴光明穴等。

根据神经分布选穴：可选用支配手术区的神经附近的腧穴，或直接刺激神经干，也可选用同节段神经附近的腧穴。如下肢手术用第三、四腰神经、股神经、坐骨神经等；甲状腺手术选取扶突（颈浅神经丛）。

以上四种选穴法，可单独使用，也可配合使用。

（2）耳针选穴：耳针选穴方法有以下三种：

根据脏象学说选穴：如因“肺主皮毛”，切开皮肤多选用肺穴，因“脾主肌肉”，切肌肉多选用脾穴；因“肾主骨”，切骨多选用肾穴；因“肝开窍于目”眼手术多选用肝穴等。

选用与手术部位相应的耳穴：根据各种疾病在耳廓上的相应反应点来选用。如兰尾切除术选兰尾穴，肺手术取肺穴， 胆囊手术取胆囊穴，甲状腺手术选用颈穴等。

根据耳穴的神经支配和解剖生理学选穴：如腹腔内脏手术选口穴、耳迷根穴，因是受迷走神经支配。又根据镇痛效果和减少内脏反射，常选用皮质下（脑）穴、交感（下脚端）穴，乃是因生理作用所决定的。

以上三种选穴法可单独选用，也可配合运用。

总之，针麻选穴，不论体针与耳针麻醉，一般多选用患侧，亦可选用健侧或双侧同用。其次是选取针刺“得气”好，针感强的穴位。

3. 常用针麻处方：常用针麻处方如表14。

部位	手术种类	穴位处方	附注
头 部	颅部和耳后切口（颅内肿瘤切除术、桥	体穴：阳交、足临泣	电针

部 位	手术种类	穴位处方	附注
	脑、小脑脚手术)	耳穴：神门、交 感、肺、肾	
头 部	额部切口（蝶鞍部病 变）	体穴：攒竹→鱼 腰、耳门→听会 百会→前顶、率谷 →角孙	电针
头 部	顶部切口（颅骨表面 疾患或脑膜瘤等）	体穴：腕骨、昆 仑、中渚、足临泣	电针
颈 部	甲状腺切除术	体穴：扶突 合谷、内关 足三里、内庭； 耳穴：交感、神门 脚、颈、膈、喉	电针
颈 部	全喉切除术	体穴配耳穴 体穴：合谷、支沟 耳穴：神门→交感 肺、肾上腺→咽 喉、颈→平喘	电针
胸 部	肺切除术	体穴：臂臑 三阳络→郄门	手法运 针或电 针
胸 部		头针：下医风 胸腔区	手法运 针或电 针

部位	手术种类	穴位处方	附注
胸部	心脏二尖瓣狭窄分离术	体穴：合谷、内关、支沟	电针
胸部	乳腺癌根治术	体穴：内关、外关、支沟	电针
腹部	脾切除术	体穴：合谷、内关、足三里、三阴交、太冲 耳穴：交感、神门、肺、脾	电针
腹部	胃部手术	体穴：足三里、上巨虚 耳穴：神门、胃、交感、肺	手法运针
腹部	胆囊切除术	体穴：合谷，内关 耳穴：神门→胆、交感、肺、松肌点	电针
腹部	阑尾切除术	耳穴配体穴 耳穴：神门、外肺交感、小肠 体穴：三焦俞，胃俞 阑尾、上巨虚，太冲	电针
腹部	疝修补术	体穴：足三里、维道 耳穴：神门→交	电针

部位	手术种类	穴位处方	附注
		感、肌松点→肺、 切口旁针	
腹部	卵巢囊肿摘除术	体穴：三阴交、公孙 内麻点（在小腿内侧，内踝直上七寸） 切口旁针（在切口两侧埋置一对毫针，电刺激）	电针
腹部	子宫肌瘤摘除术	耳穴加体穴 耳穴：交感、神门、肺，子宫 体穴：三焦俞、带脉、三阴交	电针
腹部	剖腹产	体穴：三阴交、公孙、带脉 耳穴：内麻点	电针
腹部	输卵管结扎	体穴：足三里、中都	电针
五官	扁桃体摘除术	体穴：合谷、内关 耳穴：咽喉、或扁桃体	电针
五官	拔牙	体穴：颧髂、下关（上牙） 下关、三间（上	手法运针或指压

部位	手术种类	穴位处方	附注
		牙) 颊车、承浆(下牙)	
五官	眼斜视矫正术	耳穴配体穴 耳穴：目1，目2，肝 体穴：合谷，外关	电针
五官	前臂骨折整复	患侧肢体：下扶突、天鼎	电针
五官	膝关节半月板摘除术	患侧肢体：阳陵泉、血海、气海俞	电针
五官	肩关节闭合复位术	耳穴：肩→肩关节、神门、交感、肾	电针

4. 刺激方法：在手术开始之前，预先进行一段时间的刺激称为“诱发”。诱发时间一般为10~30分钟。术中可继续刺激，亦可根据情况予以间断刺激。手术结束时起针，有的可以继续留针一段时间，以减轻手术后的疼痛。

(1) 手法运针：体针常用捻转或捻转结合提插的手法；耳针只能捻转，不能提插。运针频率每分钟120~200次为宜，捻转角度一般是90~360度之间，提插幅度在5~10毫米之间。要求始终处于“得气”状态。

手法运针应均匀稳定地进行，这是针麻的基本功，它可以根据术者手下感觉调整刺激强度。

（2）电针：操作方法同电针疗法，针麻一般用密波为主，刺激量以病人能耐受的中等刺激强度为宜。

（3）水针：选穴方法同体针。常用药物有维生素B1、度冷丁、10%葡萄糖注射液，当归注射液、延胡索注射液等。度冷丁可用生理盐水稀释。本法常和手法运针或电针配合使用。

其他还有指压穴位麻醉，器械压迫法麻醉，电极板麻醉等方法代替针刺。

[临床应用]

针刺麻醉有如上述很多优点，同时广大农村、工厂、战地均可推广使用。从针刺麻醉方法来看，要根据不同患者的适应症，选择好针麻处方，进行术前准备。首先要进行诱导试验，通过诱导可使患者适应穴位的刺激，并使情绪逐渐安定，准备接受手术。在手术时，患者能配合术者完成手术，同时也避免神经损伤，这些都是优于药物麻醉的，是外科手术麻醉方法的一种新途径，新方法。

复习思考题

- 1、针麻有什么特点？
- 2、针刺麻醉的种类有哪些？
- 3、针刺麻醉的主要步骤有哪些？
- 4、针刺麻醉的选穴原则是什么？

第三节 针麻的要求及辅助用药

[自学时数] 1学时

[目的要求]

1. 了解针刺麻醉的要求。
2. 了解针刺麻醉的辅助用药。

针麻的实践证明，除针刺作用外，辅助药物、环境条件、患者的精神因素，尤其是个体差异等也非常重要。由于针麻是在患者清醒和除痛觉以外的其它感觉都存在的情况下进行手术，同时针麻目前还存在镇痛不全、肌肉紧张和内脏牵拉反应等问题，因而对外科手术操作者提出了更高的要求。手术操作者的技术必须熟练，能稳、准、轻、快、避免重复操作，这是关系到针麻手术能否成功的一个极其重要的因素。同时手术室要保持安静，不能高声说话，以免引起患者烦躁不宁，影响手术进行。当然选用穴位适当，刺激强度要适宜，患者个体的差异以及积极配合等，都可影响针麻手术的成功，但前者尤为重要。在手术过程中，一般应避免用有齿镊子钳皮肤，切皮时应选择锋利的刀片快速切开，对肌肉层应尽量避免钝性分离，对内脏器官组织不要过多牵拉。术中辅助用药须作准备，用药即要掌握好时机，还必须注意控制剂量，严防药物的副作用。此外还应该根据手术当时的具体情况，机动灵活地改变操作步骤、改变操作方法，减少对敏感部位的刺激，对某些病灶复杂，粘连较多，或需广泛探查的病例，尤其是某些难度较高的腹腔手术，针麻效果尚不稳定，应予慎用。

针麻在手术前和手术中，常需应用少量辅助药物，以提高针麻效果。常用的主要有镇静、镇痛和抗胆碱等药物。

术前用药：通常在术前1小时肌肉注射苯巴比妥钠0.1克，术前15~30分钟肌肉或静脉注射度冷丁50毫克（有的可以不用）。为了减少呼吸道和消化道分泌物，可在手术前30~60分钟在皮下或肌肉注射阿托品0.5毫克或东莨菪碱0.3毫克。

术中用药：术中可根据患者反应和手术具体情况，分别加用镇静、镇痛药、局麻药或肌肉松弛剂等。例如在切腹膜、结扎大血管或较强烈牵引内脏等之前，估计患者可能出现较强烈反应，可预先用1%普鲁卡因作局部浸润麻醉。术中用药时机要适当，最好用在患者有可能产生剧烈反应之前，才能取得较满意的效果。药物剂量也必须适当，如用量过大，可能使患者处于朦胧状态，不能清楚地反映情况，失去与医生配合手术的能力。应用肌肉松弛剂更须慎重，必须严密观察，一有意外情况发生，就立即采取有效措施抢救。

[临床应用]

针刺麻醉是一种新的麻醉途径，在临床应用中还存在以下三种情况：如镇痛不全：针麻手术时，有的病例镇痛效果不够完全，还须在手术中途加用少量麻药，个别病例也有改用药麻的，也有的在术中某个步骤中仍感到有些疼痛。内脏牵拉反应：腹腔手术时，常因牵拉内脏或处理大血管而引起牵拉痛或其它不适感觉，甚至烦躁。在胸腔手术时，患者在开放气胸状态下，常常感到胸闷不适，呼吸困难，有时甚至发生纵膈扑动：肌肉松弛不全：在腹腔手术时，有时因腹壁肌肉松弛不全，处于比较紧张的状态，而给手术带来一定困难。因此就要求术者手技要好，操作要准确，能稳、准、轻、快地进行操作。

辅助用药，是在术前或术中应用少量的药物，以利提高针麻效果，有利手术进行。但应用时一定要掌握用药时机和用药量的大小。

总之，针麻对头面部、颈部、胸部的手术效果好，适应针麻的病例也多；腹部手术因腹肌紧张、内脏牵拉痛反应等原因，相对地适应针麻病例就少，这有待于今后进一步研究。

复习思考题

- 1、针刺麻醉有什么要求？
- 2、针刺麻醉目前还存在哪三关没有解决？
- 3、针麻常用的辅助药在手术的哪个环节应用？

更多信息

如需了解光明中医的更多信息，请扫码下面的二维码。



或者访问备用地址：www.gmzyjc.com/a

目录

中篇 针灸术	3
第一章毫针	4
第一节毫针的基本知识	5
第二节针刺练习	9
第三节针刺前的准备	12
第四节毫针刺法	17
一、进 针	18
二、针刺的角度和深度	21
三、行针与得气	24
四、针刺补泻	28
五、留针与出针	33
〔临床应用〕	34
1.针刺角度与深度:	35
2.得气:	36
3.针刺补泻:	37
第五节异常情况的处理及预防	39
第二章 灸 法 附:拔火罐疗法	47
第一节灸用材料	48
第二节灸法的分类及其操作	50
第三节灸法的作用	60
第四节灸法的注意事项	62
〔附〕拔罐法	65
第三章其他针法	71
第一节三棱针	72
第二节皮肤针	76
第三节皮疗针	80
第四节火 针	83
第五节电针	86
第六节水针	90
第七节耳 针	95
一、耳廓表面解剖	96
二、耳与经络脏腑的关系	98

三、耳穴的分布	99
四、常用耳穴的定位和主治	101
五、耳针的应用	104
(一)选穴处方原则	105
(二)操作方法	107
六、注意事项	109
〔临床应用〕	110
第八节头针	111
第四章其他针法	121
第一节针麻概念和简史	122
第二节针麻特点和方法	124
一、针麻特点	125
二、针麻方法	127
第三节针麻的要求及辅助用药	134
更多信息	136